JHOYCE DOS SANTOS SOUZA

ACESSO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS NA REGIÃO DOS LAGOS DO RIO DE JANEIRO: UM ESTUDO TRANSVERSAL SOBRE A PERSPECTIVA DOS USUÁRIOS E OS DESAFIOS DA GESTÃO EM SAÚDE.

MACAÉ

2024

JHOYCE DOS SANTOS SOUZA

ACESSO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS NA REGIÃO DOS LAGOS DO RIO DE JANEIRO: UM ESTUDO TRANSVERSAL SOBRE A PERSPECTIVA DOS USUÁRIOS E OS DESAFIOS DA GESTÃO EM SAÚDE.

Trabalho de conclusão de curso (TCC) apresentado ao Curso de Farmácia do Instituto de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Rio de Janeiro do Centro Multidisciplinar UFRJ-Macaé, como requisito para obtenção do título de farmacêutico.

Orientadora: Profa. Dra. Isabella Piassi Dias Godói

MACAÉ

2024

AGRADECIMENTOS

A Deus em primeiro lugar, por me sustentar, orientar, capacitar por todos esses anos e por enviar um incentivo maior em forma física para chegar até aqui, meu filho. Esse que reiniciou os meus anos acadêmicos de forma jamais pensada.

João Maurício(filho), gratidão ao companheirismo e força que me passava só de está ao meu lado, aceitar e colaborar com os dias que caminhava comigo para as aulas, intitulado "babyfarma" desde a barriga, e que será lembrado por muitos amigos da UFRJ.

Ao meu irmão e à minha mãe que acreditaram em mim quando nem eu mais acreditava, e estão vibrando ainda mais como forma de incentivo.

Aos amigos que fiz ao longo da caminhada, tanto os que passaram e foram capazes de colaborar e aceitar a presença do João nas aulas, e os que ficarão na minha vida para sempre (Kamila e Michael).

Aos familiares e amigos externos que abriram mão de momentos nas suas vidas para ficarem com João nas aulas práticas (Géssica, Jaqueline, Yasmin), vocês fortaleceram e firmaram meus passos nessa fase final!

Aos mestres que dedicaram e compartilharam seus conhecimentos e incentivos durante toda a graduação, fazendo com que a identificação com a profissão de Farmacêutico tivesse cada vez mais relevância para minha vida.

E por fim, e não menos importante, pelo contrário, minha gratidão eterna àquela que foi minha professora, orientadora, incentivadora, companheira e amiga, Dra. Isabella que acolheu, se doou e vibrou a cada resultado desse trabalho.

“Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento, pois ela é mais proveitosa do que a prata, e rende mais do que o ouro”. (Provérbios, 3:13-14)

RESUMO

Introdução: Avaliar o acesso e a qualidade dos serviços na perspectiva dos usuários é uma tarefa importante no processo de avaliação para identificar prioridades de saúde. Poucos são os estudos ainda publicados nesta temática, considerando o cenário do Estado do Rio de Janeiro e nenhum estudo encontra-se publicado envolvendo a Baixada Litorânea. **Objetivos:** O presente estudo tem dentre seus objetivos demonstrar a percepção dos indivíduos da Baixada Litorânea, no Estado do Rio de Janeiro, referente a aspectos como a relevância do SUS, acesso e qualidade dos serviços ofertados. Além disso, busca compreender e apresentar informações importantes para o desenvolvimento de planos estratégicos de saúde. **Métodos:** Um estudo transversal foi realizado com 200 participantes da Baixada Litorânea do Estado do Rio de Janeiro/Brasil, entre agosto e novembro/2023 para analisar alguns aspectos aplicados à saúde como acesso e qualidade dos serviços, o qual foi aplicado um questionário com 66 perguntas fechadas. Avaliou-se algumas associações entre variáveis categóricas, sendo estas analisadas pelo teste Qui-Quadrado de Pearson, utilizando Software R. Ressalta-se que o projeto foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio de Janeiro/Campus Macaé (CAAE: 68864623.6.0000.5699). **Resultados:** Após a primeira etapa da análise com os 200 participantes, constatamos que 67% dos entrevistados eram do sexo feminino, 97,5% dos indivíduos relataram utilizar os serviços do SUS, 64% dos entrevistados compram seus medicamentos em farmácias privadas, destes, 43,1% compram mediante prescrição médica. Dentre os serviços do SUS mais utilizados foram para vacinação (39%) e consultas médicas (29%). Participantes que relataram utilizar com maior frequência os serviços do SUS, consideram o SUS como essencial (p-valor=0,031). Além disso, o acesso foi considerado ruim apenas para os entrevistados que raramente e/ou às vezes utilizam os serviços públicos de saúde (p-valor=0,002). Adicionalmente, o acesso à consulta com especialistas, em geral, foi relatado ser disponível apenas em outro município da residência do participante (p-valor = 0,001). Para os indivíduos que mais utilizam o SUS, a qualidade dos serviços foi considerada nem boa nem ruim (p-valor=0.000). Não foram encontrados resultados estatisticamente significativos (p-valor>0,05) em relação à visão dos participantes sobre infraestrutura, força de trabalho e serviços. **Conclusão:** Este estudo forneceu informações importantes sobre a percepção/experiências dos usuários do SUS em uma importante região do Estado do

Rio de Janeiro e evidenciou dificuldades de acesso a algum tipo de serviços como a aquisição de medicamentos e realização de serviços especializados no município de residência. Além disso, as pessoas que utilizam apenas o SUS os consideram mais indispensáveis e os que mais utilizam os serviços públicos de saúde foram aqueles que reconheceram a importância deste sistema no atendimento das demandas e necessidades da população. Torna-se relevante a realização de estudos como este, a fim de melhor contribuir para discussões e reflexões sobre desafios, demandas e estratégias no contexto da formulação de políticas públicas de saúde, para que gestores possam compreender as reais necessidades da população.

Palavras-chave: Acesso; Qualidade; Serviços de saúde; Experiências; Usuários; Saúde pública.

ABSTRACT

Introduction: Assessing access and quality of services from the users' perspective is an important task in the evaluation process to identify health priorities. There are few studies yet published on this topic, considering the scenario of the State of Rio de Janeiro and no study has been published involving the Coastal Lowlands. **Objectives:** The present study aims to demonstrate the perception of individuals in the Coastal Lowlands, in the State of Rio de Janeiro, regarding aspects such as the relevance of the SUS, access and quality of services offered. Furthermore, it seeks to understand and present important information for the development of strategic health plans. **Methods:** A cross-sectional study was carried out with 200 participants from the Coastal Lowlands of the State of Rio de Janeiro/Brazil, between August and November/2023 to analyze some aspects applied to health such as access and quality of services, in which a questionnaire was applied with 66 closed questions. Some associations between categorical variables were evaluated, which were analyzed by Pearson's Chi-Square test, using Software R. It should be noted that the project was previously approved by the Ethics Committee of the Federal University of Rio de Janeiro/Campus Macaé (CAAE: 68864623.6.0000.5699). **Results:** After the first stage of the analysis with 200 participants, we found that 67% of respondents were female, 97.5% of individuals reported using SUS services, 64% of respondents buy their medicines in private pharmacies, of these, 43.1% buy with a medical prescription. Among the most used SUS services were vaccinations (39%) and medical consultations (29%). Participants who reported using SUS services more frequently considered the SUS to be essential (p-value=0.031). Furthermore, access was considered bad only for those interviewed who rarely and/or sometimes use public health services (p-value=0.002). Additionally, access to consultation with specialists, in general, was reported to be available only in another municipality in the participant's residence (p-value = 0.001). For individuals who use the SUS the most, the quality of services was considered neither good nor bad (p-value=0.000). No statistically significant results (p-value>0.05) were found in relation to participants' views on infrastructure, workforce and services. **Conclusion:** This study provided important information about the perception/experiences of SUS users in an important region of the State of Rio de Janeiro and highlighted difficulties in accessing some types of services such as purchasing medicines and providing specialized services in the

municipality of residence . Furthermore, people who only use the SUS consider them more indispensable and those who use public health services the most were those who recognized the importance of this system in meeting the demands and needs of the population. It is important to carry out studies like this, in order to better contribute to discussions and reflections on challenges, demands and strategies in the context of formulating public health policies, so that managers can understand the real needs of the population.

Keywords: Access; Quality; Health services; Experiences; Users; Public health.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. (**A**) Estado do Rio de Janeiro. (**B**) Região da Baixada Costeira do Estado do Rio de Janeiro.....…….....**20**

Figura 2. Perfil dos serviços do SUS utilizados pelos entrevistados ...…….....**26**

Figura 3. Perfil das consultas médicas utilizado pelos entrevistados ... ……....**26**

Figura 4. Dificuldades relatadas pelos entrevistados associadas ao uso de medicamentos.....**27**

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Características dos participantes …….....**24**

Tabela 2. Perfil clínico dos participantes que referiram suas doenças …….....**25**

Tabela 3. Percepções dos usuários do SUS sobre a relevância, o acesso e a qualidade dos serviços públicos de saúde.....**28**

Tabela 4. Percepção dos usuários do SUS aplicada aos farmacêuticos e seus serviços..... **29**

Tabela 5. Avaliação e qualidade do acesso aos serviços públicos de saúde dos usuários..... **30**

LISTA DE ABREVIAÇÕES

SUS Sistema Único de Saúde

PNS Pesquisa Nacional de Saúde

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar

PNI Programa Nacional de Imunizações

OMS Organização Mundial da Saúde

SNT Sistema Nacional de Transplantes

AP Atenção Primária

PMAQ-AB Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade de Atenção Básica

PNAUM Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos

PMAQ Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica

PIB Produto Interno Bruto

BRL Real Brasileiro

USD United States Dollar

SUMÁRIO

1. Introdução **13**

2. Justificativa **17**

3. Objetivos **18**

3.1. Objetivo geral **18**

3.2. Objetivos específicos **18**

4. Métodos **19**

4.1 Desenho e local de Estudo **19**

4.2 Instrumento de pesquisa e estudo piloto **20**

4.3 Coleta de Dados e Critérios de Inclusão **21**

4.4 Análise dos dados **22**

4.5 Aspectos Éticos **22**

5. Resultados **23**

5.1 Características da população **23**

5.2 Percepções dos Usuários do SUS sobre Acesso e Qualidade dos Serviços de Saúde **27**

6. Discussão **31**

7. Conclusão **34**

8. Referências **35**

9. Apêndices **42**

9.1 Questionário sobre avaliação do acesso e qualidade dos serviços em saúde **43**

9.2 Artigo submetido **47**

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, o livre acesso aos serviços de saúde para todo cidadão no país, passou a ser um direito de cidadania a partir da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196 (BRASIL, 2000). A regulação do sistema público de saúde brasileiro ocorreu com as Leis n° 8080 (BRASIL,1990a) e n° 8142 (BRASIL, 1990b) de 1990, que estabeleceram um sistema universal de saúde, baseado em princípios fundamentais como integralidade, descentralização e participação social (BRASIL, 1990a; BRASIL, 1990b; MATTA, 2007; BRASIL, 2016a). Segundo Castro e colaboradores (2019), a trajetória de desenvolvimento e expansão do Sistema Único de Saúde (SUS) tem demonstrado muitos desafios para o cumprimento de seu mandamento constitucional de prover "saúde para todos", em um país altamente desigual e com poucos recursos financeiros, e destacou a importância da participação social no processo de fortalecimento do SUS (BRASIL, 2010; CASTRO et al.,2019).

O SUS organiza e presta serviços e ações de saúde em diferentes níveis no Brasil, incluindo a atenção primária e especializada (secundária e terciária) (BRASIL, 2010; BRASIL, 2022). Evidências sugerem que os sistemas de saúde liderados pela atenção primária aumentem a qualidade e a capacidade de resposta e resolução de demandas locais enfrentadas pelos usuários (DONABEDIAN, 1980; STARFIELD, 2005; NESCON, 2015) e permitem maior capacidade de abordar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Cobertura Universal de Saúde (UHC) da Organização Mundial da Saúde (OMS).O relatório conjunto OMS/Banco Mundial/OCDE de 2018 afirma que: "os cuidados primários acessíveis e de alta qualidade devem ser a base para todos os outros serviços" (WHO, 2018) e defende um foco em sete domínios da qualidade dos cuidados. Estes foram efetividade, segurança, centramento nas pessoas, pontualidade, integração do cuidado, equidade e eficiência. Segundo o Ministério da Saúde no Brasil, a maioria das demandas de saúde pode ser abordada na atenção primária (BRASIL, 1990a), o que enfatiza sua importância para os sistemas de saúde como principal porta de entrada dos usuários ao SUS (SIMÃO et al., 2017; SENN et al., 2021; MACINKO, 2023).

Nos últimos anos, muitos projetos e estratégias têm sido promovidos pelo Ministério da Saúde no Brasil voltados para o nível da Atenção Primária à Saúde (APS), incluindo o Programa Nacional de Imunizações (PNI), que tem garantido o fornecimento de vacinas à população desde sua implantação, em 1973 (BRASIL,

2023a; DOMINGUES et al., 2020). O PNI, como parte do SUS, fornece dezessete vacinas para crianças, sete para adolescentes e cinco para adultos e idosos, gratuitamente, e três especialmente para gestantes das Unidades Básicas de Saúde e Estratégias de Saúde da Família, protegendo a população contra mais de 20 doenças (BRASIL, 2022). A morbimortalidade tem sido reduzida devido a essa estratégia de saúde pública, com foco na prevenção, e programa fundamental do SUS, pois contribuiu significativamente para o controle de diversas doenças imunopreveníveis 1973 (BRASIL, 2023a). Estes incluem a erradicação da varíola em 1973, a eliminação da rubéola e rubéola congênita em 2015, sarampo em 2016 e tétano neonatal em 2020 (DOMINGUES et al., 2020).

Durante a pandemia COVID-19, o PNI facilitou a imunização coletiva contra SARS-CoV-2, seguindo a introdução de vacinas eficazes em diferentes grupos etários (BRASIL, 2023a; BRASIL, 2024), com o financiamento público para a aquisição dos imunobiológicos. Até março de 2024, um total de 553.562.962 doses foram administradas no país contra o SARS-CoV-2, desde o início da vacinação (BRASIL, 2024). Os serviços de imunização contra a Covid-19 foram oferecidos pela Atenção Primária à Saúde (APS) e reforçaram o PNI como um dos mais importantes programas de saúde do Brasil, inserido no SUS.

O SUS disponibiliza uma rede de serviços para mais de 203 milhões de habitantes, distribuídos em mais de 5500 municípios (26 Estados e Distrito Federal) em todo o país, dos quais aproximadamente 70% possuem população entre 10 e 20 mil habitantes (IBGE, 2023a). A importância da colaboração e parceria local possibilita a prestação de serviços de saúde às suas respectivas populações, dadas as inúmeras limitações e desafios logísticos e de infraestrutura, bem como as questões culturais e socioeconômicas enfrentadas na prestação de cuidados de saúde por cada localidade (BRASIL,2010; CASTRO et al.,2019). Consequentemente, torna-se relevante a realização de estudos envolvendo intervenções locais, regionais ou nacionais, a fim de melhor avaliar a percepção dos usuários quanto ao acesso e à qualidade da atenção à saúde do SUS no Brasil.

Ao lado dos serviços do SUS, o mercado privado brasileiro de planos de saúde é regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que atua em nome do Ministério da Saúde (BRASIL, 2012). O seguro de saúde privado pode ser adquirido individualmente ou obtido como um benefício de trabalho, dependendo do

empregador. Os indivíduos que decidem adquirir um seguro de saúde privado ainda podem acessar a assistência à saúde pública (BRASIL, 2023a). De acordo com a ANS, 51.035.365 indivíduos possuem plano privado de saúde (março de 2024) no país, o que corresponde a, aproximadamente, 25% da população (ANS, 2024).

O acesso oportuno aos serviços de saúde é um componente crucial e um pré-requisito para a prestação de cuidados de qualidade (SAMUELSON-LIRALY et al., 2020; ANS, 2024). Existem alguns estudos publicados no Brasil em relação à gestão dos serviços públicos de saúde nos níveis federal, estadual e municipal (NATALIA SILOS ALVES et al., 2024), à qualidade dos serviços de saúde (BITTENCOURT et al., 2016; SIMÃO et al.,2017; STOPA et al., 2017; DE FÁTIMA VASQUES MONTEIRO et al., 2019; VILARINS; PINHO, 2021) e aos serviços públicos farmacêuticos (RAFAELA et al., 2016 ; HERCOS; BEREZOVSKY, 2017 ; SOEIRO et al.,2017 CARVALHO et al.,2019) .

O conceito de acesso é amplo e requer uma compreensão multidimensional com aspectos políticos, socioeconômicos, técnicos e organizacionais, com o objetivo de possibilitar que os usuários utilizem os serviços de saúde para atender às suas necessidades (GARCIA et al., 2020). É importante diferenciar os termos acesso, acessibilidade e disponibilidade, e diferenciar o acesso oportuno aos serviços de saúde do acesso físico aos serviços. Com efeito, o acesso envolve aspectos fundamentais como as dimensões geográficas, a economia, a cultura e os serviços oferecidos (SOUZA et al., 2008). Tendo em vista que o Brasil é um país com muitas particularidades locais e regionais dentro e fora do cenário de saúde, é relevante avaliar os contextos dos serviços de saúde em termos de acesso e qualidade dos serviços oferecidos, na perspectiva dos usuários do SUS em suas diferentes localidades e o vínculo estabelecido. (SEIXAS et al., 2019).

Serviços da APS quando concretizados com êxito podem melhorar os resultados de saúde não apenas individual, mas também coletivo, juntamente com a contribuição para a redução dos custos de saúde pública, o alcance de uma maior eficiência do cuidado e a possibilidade de permitir a identificação de déficits de qualidade nos serviços de saúde, como tempos de espera ou indisponibilidade de profissionais ou serviços de saúde (OMS, 2010b; THE COMMONWEALTH FUND, 2021; NUNES, 2023; OECD iLibrary, 2024) . Identificar e melhorar as deficiências será um foco fundamental para programas futuros.

O presente estudo teve como objetivo conhecer as percepções e experiências de indivíduos da Região dos Lagos, no Estado do Rio de Janeiro, sobre aspectos como acesso e a qualidade dos serviços oferecidos pelo SUS, bem como o perfil de utilização dos serviços de saúde nessa região do Brasil. Compreender as percepções e necessidades dos usuários do SUS é essencial para o monitoramento e avaliação dos sistemas públicos de saúde e para auxiliar no futuro planejamento e gestão dos serviços de saúde nesta região.

2. JUSTIFICATIVA

O SUS é um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo e tem como princípio fundamental a Universalidade, garantindo que todos os cidadãos brasileiros tenham acesso aos serviços de saúde necessários, independentemente de sua condição socioeconômica. Adicionalmente, destaca-se que a qualidade dos serviços de saúde representa um importante aspecto a ser avaliado e promovido, uma vez que influencia diretamente a saúde e o bem-estar da população (BRASIL,1990a; BRASIL, 1990b; MATTA, 2007).

Poucos ainda são os estudos publicados no Brasil e, principalmente, no contexto do Estado do Rio de Janeiro, que avaliaram aspectos como acesso e qualidade dos serviços de saúde, na perspectiva dos usuários, importantes e fundamentais no processo de fortalecimento e crescimento deste complexo sistema público de saúde.

Trata-se de um estudo inédito envolvendo a Região dos Lagos (Baixada Litorânea) do Estado do Rio de Janeiro, o qual busca-se contribuir com as análises e discussões acerca das fragilidades e desafios dos serviços do SUS, ofertados a uma população, sendo a maioria SUS-dependente (97,5%).

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Avaliar as percepções e experiências dos usuários do SUS sobre o acesso e a qualidade dos serviços públicos de saúde no cenário da Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro.

3.2 Objetivo específico

- Apresentar as percepções dos usuários da Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro, a respeito das fragilidades e desafios referente aos serviços ofertados no SUS;
- Contribuir com as discussões e reflexões sobre as demandas em saúde desta região, direcionada a ações de planejamento e gestão dos serviços em saúde pública.
- Avaliar o conhecimento e uso de medicamento além dos serviços farmacêuticos prestados pelo SUS na Região dos Lagos.

4. MÉTODOS

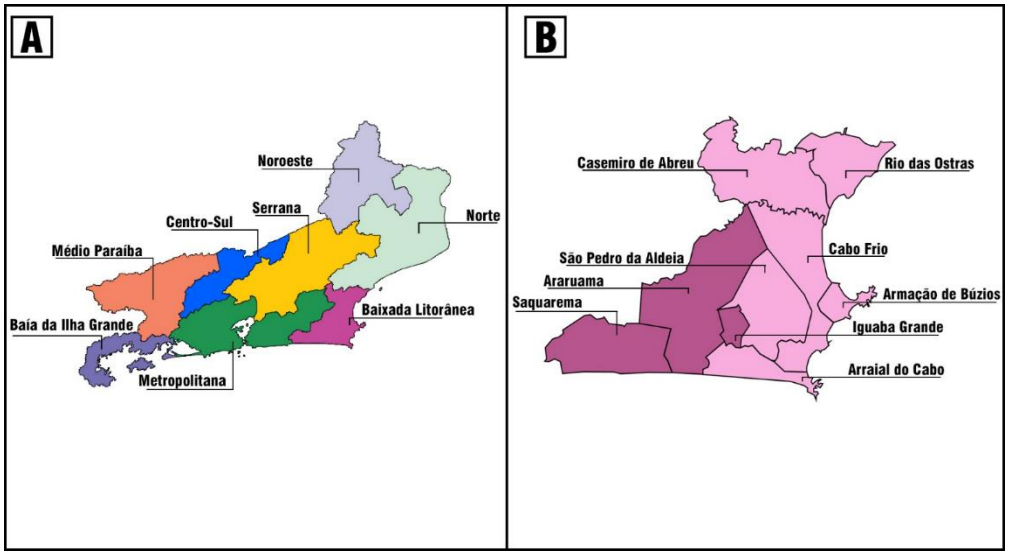
4.1 Desenho e Local do Estudo

Foi realizado um estudo transversal para avaliar as percepções dos indivíduos da Região dos Lagos (Baixada Litorânea) do Estado do Rio de Janeiro, sobre aspectos como o acesso e a qualidade dos serviços de saúde do SUS. Este estudo foi realizado em duas etapas: primeira etapa: questões descritivas e análise incluindo todos os participantes (n = 200) relacionadas com a caracterização da amostra (por exemplo, sexo, idade, escolaridade e renda familiar) e o perfil geral de utilização dos serviços de saúde; Segundo passo: percepções dos usuários sobre o acesso e a qualidade do sistema público de saúde/SUS.

Dentro do Brasil, o Estado do Rio de Janeiro encontra-se na região sudeste do país com, aproximadamente, 16 milhões de habitantes (IBGE, 2022), divididos em oito regiões, sendo estas a Metropolitana, Médio Paraíba, Fluminense Centro-Sul, Serra, Região dos Lagos (Baixada Litorânea), Norte Fluminense, Noroeste Fluminense e Baía da Ilha Grande, conforme apresentado na Figura 1A (KUSCHNIR, 2010). A Região dos Lagos é uma das principais regiões do Estado, contendo nove municípios, incluindo Cabo Frio e Rio das Ostras, conforme ilustrado na Figura 1B (RIO DE JANEIRO,2020). A população da região do estudo cresceu significativamente nos últimos anos e passou por muitas transformações socioeconômicas, incluindo recursos diretos e indiretos derivados da exploração de petróleo e do turismo (RIO DAS OSTRAS,2024). Essas mudanças têm contribuído para o aumento da demanda aos serviços de saúde, sem a compreensão da visão dos moradores sobre os serviços públicos de saúde oferecidos. Até o momento, nenhum estudo avaliou a experiência dos usuários sobre o acesso e a qualidade dos serviços de saúde nesta região.

Este estudo incluiu os seis principais municípios dessa região em termos de características demográficas e socioeconômicas, como Rio das Ostras, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, São Pedro da Aldeia, Armação dos Búzios e Arraial do Cabo, localizados entre 135 e 170 km da capital do estado (Rio de Janeiro) (RIO DE JANEIRO, 2024). Ressalta-se que o município de Cabo Frio tem 222.161 habitantes e um PIB *per capita* de BRL 52.801,54 (USD 10,475.69) (IBGE, 2023 b), enquanto Rio das Ostras tem 156.491 habitantes e um PIB *per capita* de BRL 56,096.82 (USD 11.126,34) (IBGE, 2023b).

Figura 1. (A) Estado do Rio de Janeiro. (**B**) Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro.



Nota: os municípios envolvidos neste estudo foram destacados na cor rosa claro (**B**).

4.2. Instrumento de pesquisa e estudo piloto

O questionário (Apêndice) foi elaborado com a participação de alunos do Instituto de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Rio de Janeiro do Centro Multidisciplinar UFRJ-Macaé, juntamente com a professora responsável (IPDG) deste estudo. A maioria das questões incluídas no questionário foram obtidas de projetos anteriores do Ministério da Saúde (BRASIL,2011; BRASIL,2016b). De modo geral, foi criado um questionário aplicado por entrevistador, a partir de publicações do Ministério da Saúde, como a Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos (PNAUM) e o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) (BRASIL,2011; BRASIL,2016b). O instrumento continha 66 questões, organizadas em quatro seções: (A) Perfil Socioeconômico e de Utilização de Serviços de Saúde; (b) Condição Clínica; (c) Uso de Medicamentos; e (D) Percepções e Uso de Serviços Públicos de Saúde. Vale ressaltar que, a última seção do questionário (D), responderam apenas os participantes que relataram utilizar dos serviços do SUS (Segunda etapa: avaliar a percepção dos usuários sobre o acesso e a qualidade dos serviços do SUS) e nas seções anteriores (A, B e C) todos os participantes (n = 200) (primeira etapa – Análise descritiva).

Para aumentar a robustez do questionário, este foi testado com 30 indivíduos do município de Macaé (Região Norte Fluminense) próximo ao Centro

Multidisciplinar UFRJ-Macaé. Comentários foram incluídos no questionário final do estudo principal. O pré-teste confirmou que nenhuma pergunta precisava ser alterada.

4.3. Coleta de Dados e Critérios de Inclusão

A coleta de dados foi realizada entre agosto e novembro de 2023 na Região dos Lagos (Baixada Litorânea), envolvendo 6 municípios, conforme descrito acima. O cálculo amostral seguiu a proporção da respectiva população regional e resultou em uma amostra final de 200 participantes. A aplicação dos questionários envolveu 6 localidades da Região da Baixada Litorânea, cada uma com um quantitativo de questionários, seguindo uma proporção populacional, os quais ficaram 10 para Arraial do Cabo, 36 em São Pedro da Aldeia, 14 em Casimiro de Abreu, 56 em Rio das Ostras, 72 em Cabo Frio e 12 em Armação dos Búzios.

Indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos (maioria legal no Brasil) foram recrutados por amostragem de conveniência, permitindo aos pesquisadores obter uma variedade de atitudes e opiniões (GALLOWAY, 2005). Os participantes que declararam nunca ter utilizado os serviços do SUS foram questionados na Primeira Etapa (seções A, B e C). Aos participantes que relataram utilizar os serviços do SUS, responderam a todas as perguntas e participaram das duas etapas de análises previstas deste estudo, conforme já mencionado.

Além disso, os indivíduos que referiram comprar apenas medicamentos em farmácias privadas também foram excluídos da Segunda Etapa, que envolveu questões referentes à assistência farmacêutica no sistema público de saúde.

A coleta de dados foi realizada por cinco estudantes de graduação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Rio de Janeiro do Centro Multidisciplinar UFRJ-Macaé, treinados pela professora responsável do projeto (IPDG). As perguntas da pesquisa foram aplicadas em uma entrevista, que foi realizada em português em espaços públicos, incluindo mercados públicos, praças e avenidas. Os participantes foram convidados a participar da pesquisa de forma voluntária e os objetivos da pesquisa foram explicados. Solicitou-se aos participantes que concordaram em participar da pesquisa que lessem e assinassem duas vias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, uma para o participante e outra para a pesquisadora.

4.4. Análise dos dados

As análises foram realizadas utilizando o software Microsoft Excel 2019 e R versão 4.3.0. A primeira etapa consistiu na análise descritiva das respostas de todos os participantes (n = 200) relativas à utilização dos serviços públicos de saúde do SUS, incluindo atenção básica, farmácia e serviços especializados, e às características da amostra, por exemplo, sexo, idade, escolaridade e renda familiar. O segundo passo teve como objetivo avaliar a percepção dos usuários sobre o acesso e a qualidade do sistema público de saúde do SUS, excluindo-se os indivíduos que declararam nunca utilizar os serviços do SUS (atenção básica, farmácia ou serviços especializados) no primeiro passo. Na segunda etapa, as questões relacionavam-se ao uso de farmácias e incluíam a experiência dos usuários de receber orientações sobre o uso de medicamentos e o papel e a presença do farmacêutico.

Além disso, avaliamos as experiências dos usuários na obtenção, adesão e dificuldades no uso de medicamentos. Além disso, avaliamos sua compreensão das bulas de medicamentos, incluindo orientações sobre o uso de antibióticos e conselhos sobre o uso concomitante de álcool, bem como polifarmácia.

As variáveis categóricas foram descritas por frequências absolutas e relativas. A associação entre as variáveis categóricas foi analisada pelo teste Qui-Quadrado de Pearson e considerada estatisticamente significativa quando o valor-p foi < 0,05. Além disso, foi adotado o valor de conversão fornecido pelo Banco Central do Brasil (2023: US$ 1, R$ 5,04) (BRASIL, 2023b).

4.5. Aspectos Éticos

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro do Centro Multidisciplinar da UFRJ- Macaé (CAAE: 68864623.6.0000.5699).

5. RESULTADOS

5.1. Características da população

A coleta de dados envolveu 200 participantes de diferentes localidades e características socioeconômicas dos seis municípios envolvidos da Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro. Foram verificados que 67% dos entrevistados eram do público feminino e 97,5% dos indivíduos relataram utilizar os serviços do SUS (n=195). A média de idade dos entrevistados foi de 44 anos (DP ± 13). Além disso, 64% dos entrevistados declararam adquirir seus medicamentos apenas de forma privada e 43,1% relataram adquirir medicamentos a partir de prescrição médica. Maiores detalhes sobre as características dos respondentes estão presentes na Tabela 1.

Tabela 1. Características dos respondentes (n = 200).

Variável	n	(%) *
Feminino	134	67.0%
Masculino	66	33.0%
Perfil Etário (anos)		
18–25	21	10.5%
26–45	103	51.5%
46–60	54	27.0%
Mais de 60	22	11.0%
Raça/cor da pele		
Branco	73	36.5%
Preto	30	15.0%
Pardo	94	47.0%
Outro	3	1.5%
Nível de escolaridade		
Nunca frequentou a escola	2	1.0%
Ensino fundamental incompleto	21	10.5%
Ensino fundamental completo	14	7.0%
Ensino médio incompleto	10	5.0%
Ensino médio completo	54	27.0%
Ensino superior incompleto	36	18.0%
Ensino superior completo ou mais	63	31.5%
***Renda familiar * (número de salários mínimos) ** ***		
Até 1	17	8.5%
1–2	46	23.0%
2–3	42	21.0%
3–5	51	25.5%
5–10	27	13.5%
10–20	3	1.5%
>20	2	1.0%
Uso dos serviços do SUS — Sim	195	97.5%
Tem plano de saúde privado — Sim	95	47.5%

Notas: * Renda familiar: Alguns entrevistados não responderam a essas questões ("não sei/não quero responder"); ** Salário mínimo em 2023: R$ 1.320,00 (BRASIL, 2023c).

Hipertensão, ansiedade, depressão, diabetes mellitus, artrite e doenças respiratórias foram as condições autorreferidas mais comuns entre os participantes, com 38% da amostra relataram ter duas ou mais doenças e 23% dos participantes relataram nenhuma condição clínica. O perfil clínico dos participantes é apresentado na Tabela 2.

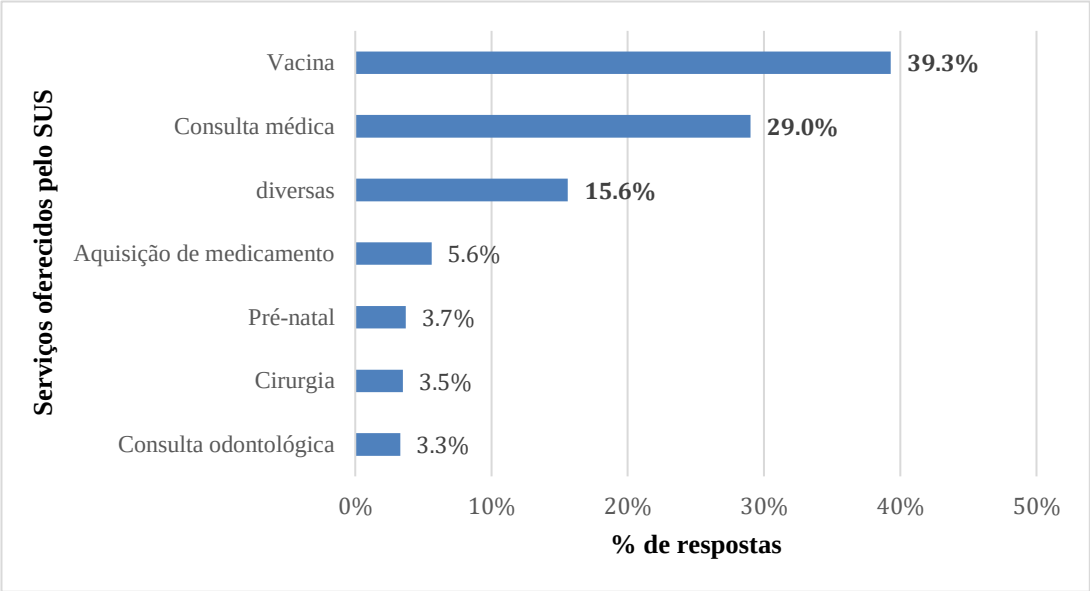
Tabela 2. Perfil clínico dos participantes que referiram suas doenças advindos da Região da Baixada Litorânea (n = 154).

Condição Clínica	%
Outras doenças respiratórias	26,2%
Ansiedade/Depressão	13,8%
Hipertensão	12,4%
Outras doenças	12,0%
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica	11,3%
Dislipidemia	10,5%
Distúrbios articulares	7,7%
Diabetes Mellitus	3,1%
Problemas Cardiovasculares	3,0%

Nota: no total, 46 (23%) participantes relataram não apresentar nenhuma condição clínica.

Entre os indivíduos que declararam utilizar os serviços do SUS (n = 195), 128 (64%) relataram adquirir medicamentos em farmácias privadas, enquanto 67 (36%) adquirem medicamentos em farmácias públicas. Destaca-se que a vacinação (39%) e consultas médicas (29%) foram os serviços do SUS mais utilizados pelos entrevistados, conforme apresentado na Figura 2.

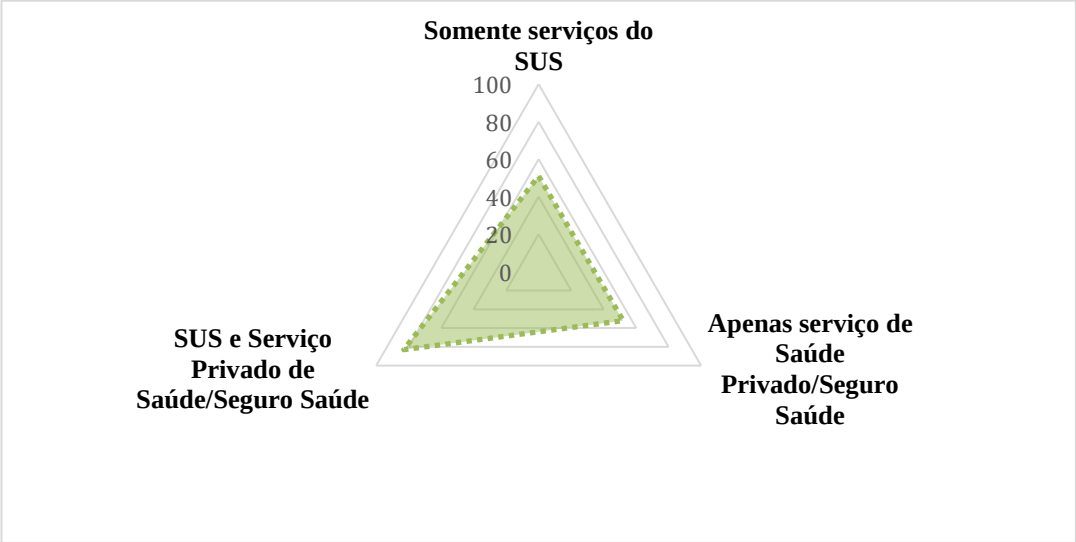
Figura 2. Perfil dos serviços do SUS utilizados pelos entrevistados advindos Região da Baixada Litorânea (n=195).



Nota: os participantes podiam registrar mais de um serviço.

No geral, 42,1% dos entrevistados declararam utilizar tanto o SUS quanto os serviços privados (convênios ou individualmente) para realização de consultas médicas, 26,4% utilizaram apenas o atendimento privado, 26,0% utilizaram apenas os serviços do SUS e 5,5% não quiseram responder a essa pergunta, apresentado na Figura 3.

Figura 3. Perfil de utilização dos serviços em saúde pelos entrevistados advindos Região da Baixada Litorânea (n=195).

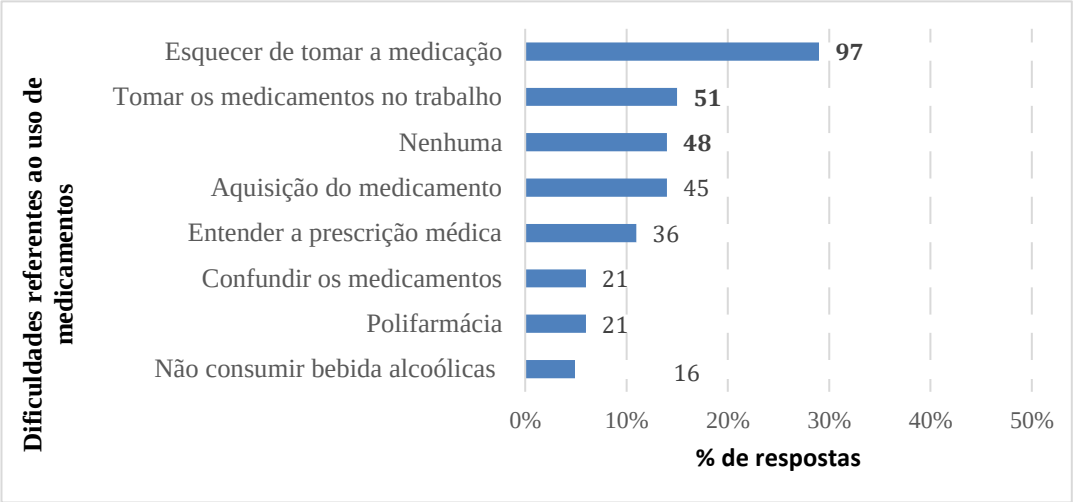


Nota: um total de cinco participantes não quiseram responder a esta questão.

A maioria (87,7%) dos entrevistados relatou fazer uso de medicamentos isentos de prescrição médica, bem como "usar o medicamento pelo fato de já tê-lo em casa".

Adicionalmente, várias dificuldades foram registradas pelos entrevistados em relação ao uso de medicamentos, entre estas o esquecimento de tomar os medicamentos (29%) e a obtenção de medicamentos nos serviços do SUS (14%), conforme apresentado na Figura 4.

Figura 4. Dificuldades relatadas pelos entrevistados advindos Região da Baixada Litorânea ,associadas ao uso de medicamentos (n=200).



Nota: os participantes podiam registrar mais de uma dificuldade.

Para 70,6% dos entrevistados, segurança, funcionalidade e conforto do paciente estão entre as principais demandas e prioridades para ser melhorados referente aos serviços do SUS. Além disso, 12,1% dos participantes relataram que deveria haver um aumento no número de unidades do SUS para melhorar a acessibilidade, e 10,7% indicaram que deveria haver uma melhoria na facilidade de obtenção de medicamentos nas farmácias públicas do SUS.

5.2. Percepções dos Usuários do SUS sobre Acesso e Qualidade dos Serviços de Saúde

Dos 200 participantes, conforme mencionado, 195 (97,5%) declararam utilizar o SUS. Os participantes que utilizaram mais os serviços públicos de saúde (*sempre* e/ou *frequentemente*: n = 195) consideraram o SUS como indispensável e essencial à população. Aqueles que fazem uso *às vezes* e/ou *raramente* relataram considerar o SUS como um sistema complementar de saúde (valor-p=0,031), conforme apresentado na Tabela 3.

Em geral, o acesso foi considerado ruim para os entrevistados que utilizaram os serviços públicos *raramente* ou *às vezes* (valor-p=0,002). Além disso, em uma análise de correlação entre as variáveis “qualidade dos serviços do SUS” e a

"frequência de utilização desses serviços", aqueles que utilizam mais frequentemente os serviços públicos de saúde tenderam a considerar a qualidade da assistência como boa ou ruim (valor-p=0,000), conforme observado na Tabela 3.

Tabela 3. Percepções dos usuários advindos Região da Baixada Litorânea, do SUS sobre a relevância, o acesso e a qualidade dos serviços públicos de saúde conforme a frequência de utilização. (n = 195).

Relevância do SUS n (%)

Frequência	**Indispensável/Essencial**	**Complementar**	**Indiferente**	***p-Valor***
Sempre	27 (81,8%)	3 (9,1%)	3 (9,1%)	
Frequentemente	37 (100,0%)	0 (0,00%)	0 (0,00%)	
Às vezes	74 (88,1%)	6 (7,1%)	4 (4,8%)	0,031
Raramente	34 (82,9%)	7 (17,1%)	0 (0,00%)	
TOTAL	172 (88,2%)	16 (8,2%)	7 (3,6%)	

Acesso aos serviços do SUS n (%)

Frequência	**Muito bom**	**Bom**	**Nem bom nem ruim**	**Ruim**	**Muito ruim**	***p-valor***
Sempre	2 (5,7%)	12 (34,3%)	14 (40,0%)	5 (14,3%)	2 (5,7%)	
Frequentemente	0 (0,00%)	5 (13,8%)	21 (55,6%)	11 (30,6%)	0 (0,00%)	
Às vezes	1 (1,2%)	10 (12,8%)	39 (47,5%)	23 (29,5%)	7 (9,0%)	0,002
Raramente	3 (7,3%)	3 (7,3%)	15 (34,15%)	12 (29,3%)	9 (21,9%)	
TOTAL	6 (3,1%)	30 (15,8%)	90 (44,7%)	51 (26,7%)	18 (9,7%)	

Qualidade dos serviços do SUS n (%)

Frequência	**Muito bom**	**Bom**	**Nem bom nem ruim**	**Ruim**	**Muito ruim**	***p-valor***
Sempre	4 (11,8%)	8 (23,5%)	14 (38,3%)	8 (23,5%)	1 (2,9%)	
Frequentemente	1 (2,7%)	5 (13,5%)	17 (43,3%)	15 (40,5%)	0 (0,0%)	
Às vezes	0 (0,00%)	14 (16,9%)	51 (60,2%)	14 (16,9%)	5 (6,0%)	0,000
Raramente	4 (10,8%)	8 (21,6%)	10 (24,4%)	9 (24,3%)	7 (18,9%)	
TOTAL	9 (4,7%)	35 (18,3%)	92 (46,1%)	46 (24,1%)	13 (6,8%)	

No cenário farmacêutico, quando questionados sobre a presença do farmacêutico na farmácia, no momento da aquisição do medicamento, os entrevistados relataram que geralmente este profissional não está presente nas farmácias do SUS, sendo que 60% declararam nunca ter recebido um atendimento com um farmacêutico. Aqueles que adquiriram medicamentos pelos serviços públicos e privados relataram a presença do farmacêutico *sempre* (18,8%), *frequentemente* (18,8%) e *às vezes* (43,8%).

Os indivíduos que adquiriram medicamentos somente pelas farmácias do SUS consideraram o papel e/ou contribuição do farmacêutico como indiferente ao processo de orientação para o uso do medicamento, e aqueles que adquiriram medicamentos pelos dois serviços (público e privado) consideraram o farmacêutico como *indispensável* e *essencial* (na farmácia de valor-p=0,0005), como apresentado na Tabela 4.

Tabela 4. Percepção dos usuários advindos Região da Baixada Litorânea, do SUS aplicada aos farmacêuticos e seus serviços em redes públicas e privadas (n = 195).

	Presença do Farmacêutico na Farmácia n (%)					
Aquisição de Medicamentos	**Sempre**	**Frequentemente**	**Às vezes**	**Raramente**	**Nunca**	***p-valor***
Farmácia Pública	1 (10,0%)	2 (20,0%)	1 (10,0%)	0 (0,0%)	6 (60,0%)	
Público e Privado	6 (18,8%)	6 (18,8%)	14 (43,8%)	5 (15,6%)	1 (3,1%)	0,001
TOTAL	7 (16,7%)	8 (19,1%)	15 (35,7%)	5 (11,8%)	7 (16,7%)	

	Papel do Farmacêutico na orientação ao paciente n (%)			
Aquisição de Medicamentos	**Indispensável/Essencial**	**Indiferente**	**Desnecessário**	***p-valor***
Farmácia Pública	2 (22,2%)	6 (66,7%)	1 (11,1%)	
Público e Privado	42 (97,7%)	1 (2,3%)	0 (0,0%)	0,0005
TOTAL	44 (84,6%)	7 (13,5%)	1 (1,9%)	

Quanto ao acesso às consultas em serviços especializados do SUS, por exemplo, neuropediatras e cardiologistas, os participantes registraram estar, em geral, disponíveis apenas em outro município de sua residência (valor-p=0,001). Não foram encontrados resultados estatisticamente significantes (p-valor > 0,05) em relação à percepção dos participantes sobre infraestrutura, profissionais de saúde e serviços, como contemplado na Tabela 5.

Tabela 5. Avaliação e qualidade do acesso aos serviços públicos de saúde dos usuários advindos Região da Baixada Litorânea, n (%).

Acesso aos Serviços do SUS n (%)				
Acesso aos Serviços do SUS	**Infra-estrutura**	**Profissionais de Saúde**	**Serviços**	***p-Valor***
Muito bom	7(77,8%)	2 (22,2%)	0 (0,0%)	0,88
Bom	24 (75,0%)	6 (18,7%)	2 (6,3%)	
Nem bom, nem ruim	62 (75,6%)	11 (13,4%)	9 (11,0%)	
Ruim	33 (78,6%)	4 (9,5%)	5 (11,90%)	
Muito ruim	10 (76,9%)	1 (7,7%)	2 (15,4%)	
TOTAL	136 (76,4%)	24 (13,5%)	18 (10,1%)	

6.DISCUSSÃO

Acredita-se que este seja o primeiro estudo a avaliar as experiências dos usuários sobre o acesso e a qualidade dos serviços públicos de saúde nesta região do Estado do Rio de Janeiro. A maioria dos participantes utilizou o sistema público de saúde (97,5%) e os resultados demonstraram que os serviços do SUS, como a vacinação, são muito utilizados pela população brasileira. Alguns autores destacam que uma forte atenção primária à saúde é essencial para que serviços de saúde responsivos sejam oferecidos à comunidade (STARFIELD, 2005; NESCON, 2015). No entanto, nossos resultados evidenciam grandes deficiências do ponto de vista dos usuários dos serviços do SUS sobre aspectos aplicados à infraestrutura e, principalmente, administrativos e organizacionais do SUS, também registrado em outros estudos no Brasil (BOUSQUAT et al., 2017; SIMÃO et al., 2017).

No geral, apenas 23% dos participantes avaliaram a qualidade do atendimento como *muito boa* ou *boa* e apenas 18,9% classificou o acesso como *muito bom* ou *bom.* Os participantes que utilizaram os serviços do SUS *com frequência* e *às vezes*, 61,8% e 71,1%, respectivamente, relataram a qualidade dos serviços públicos de saúde do SUS como *nem bom nem ruim*. Além disso, o acesso aos serviços do SUS foi classificado como *nem bom nem ruim* por 86,2% dos participantes que utilizavam os serviços do SUS com frequência e 77,7% daqueles que utilizavam os serviços do SUS algumas vezes (p-valor = 0,002). Esses dados também mostraram que algumas mulheres relataram que os serviços de pré-natal são insatisfatórios em alguns municípios dessa região. Além disso, apenas 26% dos participantes relataram sempre conseguir obter um medicamento desejado nas farmácias públicas do SUS. Boing e colaboradores (2022) também constataram que muitos indivíduos não conseguiram obter medicamentos pelo SUS, o que foi associado à ineficiência no acesso aos serviços do SUS. Esses resultados demonstram, portanto, ainda mais a preocupação dos usuários dos serviços do SUS com o acesso e a qualidade dos serviços de saúde do SUS.

Quase metade (47,5%) dos participantes deste estudo relatou possuir plano privado de saúde, valor superior à média nacional (~25%) (ANS, 2024), embora aqueles que possuíam plano ou seguro privado de saúde também tenham referido utilizar alguns serviços do SUS. O número de indivíduos que conseguem utilizar uma

combinação de serviços de saúde públicos e privados está de acordo com pesquisas anteriores (BOUSQUAT et al.,2017). A maior frequência de indivíduos que possuem plano privado de saúde, nesta amostra, pode estar associada e/ou percebida como um reflexo dos déficits e/ou fragilidades do acesso e qualidade da atenção nos serviços do SUS, reportado pelos residentes dos municípios envolvidos da Região dos Lagos.

A Região dos Lagos (Baixada Litorânea) possui municípios (Arraial do Cabo, Armação dos Búzios e Casimiro de Abreu) com menos de 100 mil habitantes e infraestrutura insuficiente para atender algumas demandas de saúde, como, por exemplo, maternidade e consulta especializada, além de procedimentos como cirurgias e transplantes (RIO DE JANEIRO, 2020). Os participantes deste estudo relataram não ter conseguido acessar consultas com especialistas em seu município de residência. Neste contexto, ressalta-se que a regionalização é um princípio que fundamenta a construção do sistema SUS para promover e viabilizar estratégias de acesso da população aos serviços públicos. Uma vez que pessoas que residem em municípios que são "carentes de infraestrutura", devem ou deveriam receber, por exemplo, serviços como o transporte gratuito e facilidade para viabilizar deslocamento destes a outros municípios para a realização de serviços como consulta com especialistas. Segundo Carvalho e colaboradores (2017), o processo de regionalização descentralizada tem sido fundamental para garantir o acesso aos serviços do SUS, contudo desafios e fragilidades ainda são observados (CARVALHO; JESUS; SENRA, 2017).

No contexto da farmácia, muitos municípios do Estado do Rio de Janeiro não disponibilizam profissionais para atuarem em serviços como a Estratégia Saúde da Família. Além disso, nas farmácias públicas do SUS, a dispensação de medicamentos é realizada, principalmente, por outro membro da equipe que não seja um farmacêutico, o que contextualiza nosso achado de que um percentual considerável de participantes nunca consultou um farmacêutico nas farmácias públicas do SUS (60%). Peixoto et al. (2022) (PEIXOTO et al., 2022) e Torrês e colaboradores (2024) (TORRES et al., 2024) enfatizaram que a presença do farmacêutico aumenta e otimiza a dispensação de medicamentos e a entrega de conhecimento técnico sobre o uso de medicamentos aos pacientes, o que foi valorizado e reconhecido em nossa amostra, principalmente pelos entrevistados que utilizam farmácias privadas (valor-p = 0,0005)

A presença do farmacêutico também promove o uso racional de medicamentos (PEIXOTO et al., 2022; TORRES et al., 2024) .

O estudo objetivou identificar as experiências e visões dos usuários dos serviços do SUS em uma região socioeconomicamente carente do Rio de Janeiro. No entanto, algumas limitações devem ser observadas, incluindo a participação de apenas seis dos nove municípios da Região da Região dos Lagos, que têm o impacto socioeconômico mais relevante. Entretanto, conforme apresentado na Tabela 1, as características da amostra foram semelhantes às da população brasileira como um todo (IBGE,2014) A amostra de conveniência utilizada pode não ser generalizável para a população mais ampla do Brasil. No entanto, a abordagem de conveniência da amostra utilizada neste estudo facilitou a obtenção de uma variedade de atitudes e opiniões (GALLOWAY, 2005). Apesar dessas limitações, acredita-se que o estudo tenha conseguido identificar a percepção dos usuários dos serviços do SUS sobre o acesso e a qualidade dos serviços de saúde do SUS na Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro.

7. CONCLUSÃO

Trata-se de um estudo inédito, em uma das principais regiões de um importante Estado brasileiro, evidenciando a percepção dos usuários sobre os serviços públicos do SUS. No geral, apenas 23% dos participantes avaliaram a qualidade da assistência como *muito boa* ou *boa* e apenas 18,9% classificaram o acesso como *muito bom* ou *bom*, com mais de 60% dos usuários do SUS avaliando o acesso e a qualidade dos serviços do SUS como *nem bom nem ruim*. Esses resultados destacam importantes prioridades de melhoria por parte dos usuários do SUS, para considerações pelos formuladores de políticas no planejamento e na execução de reformas para melhorar o acesso futuro e a qualidade dos serviços responsivos do SUS e da cobertura universal de saúde.

Muitas pessoas no Brasil são dependentes do SUS para a saúde. O SUS tem sido essencial na promoção da saúde e no atendimento das necessidades de saúde de grande parte da população brasileira, garantindo o acesso aos serviços de saúde, promovendo a prevenção de doenças e, principalmente, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de milhões de brasileiros. Seu importante papel está intrinsecamente ligado à melhoria da saúde da população, tendo como um grande desafio promover um sistema de saúde orientado para a atenção primária, mais eficiente, acessível e centrado no paciente.

8. REFERÊNCIAS

Agency for Healthcare Research and Quality. Six Domains of Health Care Quality. Disponivel em : <https://www.ahrq.gov/talkingquality/measures/six-domains.html> Acesso em :30 Mar, 2024.

ANS. Beneficiários de Planos Privados de Saúde, por Cobertura Assistencial (Brasil—2014–2024). Disponível em :<https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-nformacao/perfil-do-setor/dados-gerais> Acesso em: 22 de Mai, 2024.

ANS. Dados Gerais. Beneficiários de Planos Privados de Saúde, por Cobertura Assistencial (Brasil—2013–2023); ANS: Brasília, Brasil, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/perfil-do-setor/dados-gerais>. Acesso em: 30 Mar, 2024.

Bittencourt, S.D.D.A.; Domingues, R.M.; Reis, L.G.; Ramos, M.M.; Leal, M.D. Adequacy of public maternal care services in Brazil. Reprod. Health 2016, 13, 120. Disponível em:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27766964/. Acesso em: 29 Mar,2024.

Boing, A.; Andrade, F.; Bertoldi, A.; Glazer, K.; Peres, A.; Massuda, A.; Boing, A. Prevalências e desigualdades no acesso aos medicamentos por usuários do Sistema Único de Saúde no Brasil em 2013 e 2019. Cad. Saúde Pública 2022, 38, e00114721. Disponível em :<https://doi.org/10.1590/0102-311XPT114721>. Acesso em: 29 Mar,2024.

Bousquat, A.; Giovanella, L.; Campos, E.M.S.; Almeida, P.F.; Martins, C.L.; Mota, P.H.D.S.; Mendonça, M.H.M.; Medina, M.G.; Viana, A.L.D.; Fausto, M.C.R.; et al. Primary health care and the coordination of care in health regions: managers' and users' perspective. Cienc. Saude Coletiva 2017, 22, 1141–1154. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28444041/>.Acesso em: 29 Mar, 2024.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 29, de 13 de Setembro de 2000. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; Presidência da República: Brasília, Brazil, 2000. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc29.htm#:~:text=EMENDA%20CONSTITUCIONAL%20N%C2%BA%2029%2C%20DE,e%20servi%C3%A7os%20p%C3%BAblicos%20de%20sa%C3%BAde>. Acesso em : 29 Feb,2024.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 95, de 15 de Dezembro de 2016; Presidência da República: Brasília, Brasil, 2016. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm>. Acesso em: 29 Fev, 2024.

BRASIL. Histórico de Cotação; Banco Central do Brasil: Brasília, Brasil, 2023b. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes>. Acesso em: 22 Fev, 2024.

BRASIL. Lei n. 14.663, de 28 de Agosto de 2023; Presidência da República: Brasília, Brasil, 2023c. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Lei/L14663.html>.Acesso em: 22 Fev, 2024.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990; Presidência da República: Brasília, Brasil, 1990. Disponivel em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>. Acesso em: 15 Jan, 2024.

BRASIL. Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1990; Presidência da República: Brasília, Brasil, 1990. Disponível em : <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm>.Acesso em: 29 Fev, 2024.

BRASIL. Lei nº. 141, de 13 de Janeiro de 2012; Diário Oficial da União: Brasília, Brazil, 2012. Disponível em: <https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2017/01/Livro_LC_141_tela.pdf>. Acesso em 15 Jan, 2024.

Cmas, D.; Maranhão, A.G.K.; Teixeira, A.M.; Fantinato, F.F.S.; Domingues, R.A.S. 46 Anos do Programa Nacional de Imunizações: Uma História Repleta de Conquistas e Desafios a Serem Superados. *Cad Saúde Pública [Internet]* **2020**, *36*, e00222919. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00222919>. Acesso em : 29 Mar,2024.

Campbell, S.M.; Roland, M.O.; Buetow, S.A. Defining quality of care. *Soc. Sci. Med.* **2000**, 51, 1611–1625. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11072882/>. Acesso em: 29 Mar, 2024.

Carvalho, M.; Queiroz, A.B.A.; Ferreira, M.A.; Moura, M.A.V.; Pinto, C.B.; Vieira, B.D.G. Ineffectiveness of information and access to health services: Vulnerability to human papillomavirus. *Int. Nurs. Rev.* **2019**, 66, 280–289. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30815859/>. Acesso em: 29 Mar, 2024.

Castro, M.C.; Massuda, A.; Almeida, G.; Menezes-Filho, N.A.; Andrade, M.V.; de Souza Noronha, K.V.M.; Rocha, R.; Macinko, J.; Hone, T.; Tasca, R.; et al. Brazil's unified health system: The first 30 years and prospects for the future. *Lancet* **2019**, *394*, 345–356. Disponivel em: <https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31243-7. PMID: 31303318>. Acesso em : 20 Mai,2024.

De Carvalho, A.L.B.; de Jesus, W.L.A.; Senra, I.M.V.B. Regionalization in the SUS: Implementation process, challenges and perspectives in the critical view of system managers. *Ciência Saúde Coletiva* **2017**, *22*, 1155–1164. Disponivel em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/X5tq3bQgN8XkGkths95ctkz/?lang=en#>. Acesso em: 20 Mai, 2024.

Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Relação de Municípios do Estado do Rio de Janeiro por data de adesão, Brasil, 2024. Disponível em: <https://www.defesacivil.rj.gov.br/index.php/cidades-resilientes/item/61-relacao-de-municipios-do-estado-do-rio-de-janeiro-por-data-de-adesao>. Acesso em: 30 *Mai*, 2024.

Diagnóstico de Saúde da Região da Baixada Litorânea; Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, Brasil 2020. Disponível em:

<https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MzUwNzA%2>. Acesso em: 28 Fev, 2024.

De Fátima Vasques Monteiro, M.; Barbosa, C.P.; Vertamatti, M.A.F.; Tavares, M.N.A.; de Oliveira Carvalho, A.C.; Alencar, A.P.A. Access to public health services and integral care for women during the puerperal gravid period period in Ceará, Brazil. BMC Health Serv. Res. **2019**, 19, 851. Disponivel em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6868722/>. Acesso em: 29 Mar, 2024.

DONABEDIAN, A., 1980. The Criteria and Standards of Quality. Ann Arbor, Michigan : Health Administration Press. (Explorations in Quality Assessment and Monitoring, v. II).

Galloway, A. Convenience Sampling—An Overview|ScienceDirect Topics. *Encyclopedia of Social Measurement. Non-Probability Sampling—Convenience Sampling*; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, 2005; ISSB 978-0-12-369398-3. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/convenience-sampling#:~:text=Convenience%20Sampling-,Definition,in%20a%20workplace%2C%20for%20example>. Acesso em 23 Mai, 2024.

Garcia, M.M.; Azevedo, P.S.; Mirelman, A.; Safatle, L.P.; Iunes, R.; Bennie, M.C.; Godman, B.; Guerra Junior, A.A. Funding and Service Organization to Achieve Universal Health Coverage for Medicines: An Economic Evaluation of the Best Investment and Service Organization for the Brazilian Scenario. *Front. Pharmacol.* **2020**, *11*, 370.

NATALIA SILOS ALVES et al. Alocação de recursos públicos para saúde em Macaé entre 2014 e 2017: Reflexões e Desafios. Jornal de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia, v. 9, n. 2, 5 abr. 2024 Disponível em: <https://ojs.jaff.org.br/ojs/index.php/jaff/article/view/811/>. Acesso em : 16 Jun, 2014.

Hercos, B.V.S.; Berezovsky, A. Quality of the ophthalmological service to outpatients of the public and private healthcare systems. Arq. Bras. Oftalmol. **2017**, *80*, 350–354. Disponível em : <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29267568/>. Acesso em: 29 Mar, 2024.

IBGE. Censo 2022. De 2010 2022, População Brasileira Cresce 6.5% e Chega a 203.1 Milhõe; IBGE: Brasília, Brasil, 2023. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/37237-de-2010-a-2022-populacao-brasileira-cresce-6-5-e-chega-a-203-1-milhoes#:~:text=A%20popula%C3%A7%C3%A3o%20do%20pa%C3%ADs%20chegou,foi%20de%200%2C52%25>. Acesso em: 29 Mar, 2024.

IBGE. Dados Sobre Estados Brasileiros. Panorama Cabo Frio, Brasil, 2023. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/cabo-frio/panorama>. Acesso em 18 Fev, 2024.

IBGE. Dados Sobre Estados Brasileiros. Panorama Rio das Ostras, Brasil, 2023. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/rio-das-ostras/panorama>. Acesso em: 18 Fev, 2024.

IBGE. Panorama; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: Rio de Janeiro, Brasil, 2022. Acesso em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/panorama>. Acesso em: 18 Fev, 2024.

IBGE. Síntese de Indicadores Sociais: Uma Análise das Condições de Vida da População Brasileira; IBGE: Brasilia, Brasil, 2014. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91983.pdf>.Acesso em: 30 Mar, 2024.

Kuschnir, R.; Chorny, A.; Lira, A.M.L.E.; Sonoda, G.; Fonseca, T.M.P. Regionalização no Estado do Rio de Janeiro: O Desafio de Aumentar Acesso e Diminuir Desigualdades. A Gestão do SUS no Âmbito Estadual: O Caso do Rio de Janeiro; Editora FIOCRUZ: Rio de Janeiro, Brazil, 2010; pp. 215–240.

Macinko, J.; Starfield, B.; Shi, L. The Contribution of Primary Care Systems to Health Outcomes within Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Countries, 1970–1998. Health Serv. Res. 2003, 38, 831–865.

Matta, G.C. Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. In Políticas de Saúde: Organização e Operacionalização do Sistema Único de Saúde; Matta, G.C., Pontes, A.L.d.M., Eds.; Coleção Educação Profissional e Docência em Saúde: A formação e o trabalho do agente comunitário de saúde, 3; EPSJV/FIOCRUZ: Rio de Janeiro, Brazil, 2007; pp. 61–80.

Ministério da Saúde. PNI: entenda como funciona um dos maiores programas de vacinação do mundo. Brasília, Brasil,2022. Disponível em: < https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/agosto/pni-entenda-como-funciona-um-dos-maiores-programas-de-vacinacao-do-mundo>. Acesso em 19 Jun, 2024.

Ministério da Saúde. *Portaria Programa Nacional de Imunizações—Vacinação*; Brasília, Brasil, 2023a. Disponível em :< https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/pni>. Acesso em :30 Mar,2024.

Ministério da Saúde. Portaria N° 4.279, de 30 de Dezembro de 2010. Estabelece Diretrizes Para a Organização da Rede de Atenção à Saúde no Âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); Brasília, Brasil, 2010. Disponível em: < https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html>. Acesso em : 30 Mar,2024.

Ministério da Saúde. Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ); Brasília, Brasil, 2011. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pmaq>. Acesso em: 23 Fev 2024.

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Componente Populacional: Introdução, Método e Instrumentos/Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos; il.—Série Pnaum—Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos no Brasil; Caderno 1; Ministério da Saúde: Brasília, Brasil, 2016; 80p. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/componente_populacional_introducao_metodo_instrumentos.pdf>. Acesso em : 23 Fev,2024.

Ministério da Saúde. Vacinômetro COVID-19; Brasília, Brasil, 2024. Disponível em: <https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_Vacina_C19/SEIDIGI_DEMAS_Vacina_C19.html>. Acesso em: 29 Mar, 2024.

Ministério da Saúde. Atenção Primária e Atenção Especializada: Conheça os níveis de assistência do maior sistema público de saúde do mundo.Brasília, Brasil, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/marco/atencao-primaria-e-atencao-especializada-conheca-os-niveis-de-assistencia-do-maior-sistema-publico-de-saude-do-mundo>. Acesso em: 16 Jun, 2024.

NESCON. *Atenção Primária deve Solucionar a Maioria dos Problemas de Saúde*; Nescon/UFMG: Belo Horizonte, Brasil, 2015. Disponível em: <https://www.nescon.medicina.ufmg.br/atencao-primaria-deve-solucionar-maioria-dos-problemas-de-saude/>. Acesso em: 16 Jan, 2024.

Nunes, L.O.; Castanheira, E.R.L.; Sanine, P.R.; Akerman, M.; Nemes, M.I.B. Performance assessment of primary health care facilities in Brazil: Concordance between web-based questionnaire and in-person interviews with health personnel. *PLoS ONE* **2023**, *18*, e0281085.

OECD. Primary Health Care in Low- and Middle-Income Countries. Realizing the Potential of Primary Health Care. OECD iLibrary. Disponível em: <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5a3b7d49-en/index.html?itemId=/content/component/5a3b7d49-en>. Acesso em: 22 Jan, 2024).

Peixoto, R.T.; Campos, M.R.; Luiza, V.L.; Mendes, L.V. O farmacêutico na Atenção Primária à Saúde no Brasil: Análise comparativa 2014–2017. Saúde Debate **2022**, 46, 358–375. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/3LgFkWC3ryTCc79YQnhSmdv/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 22 Jan, 2024.

Pinto, R.d.S; Roncalli, A.G.; Abreu, M.H.; Vargas, A.M. Use of Public Oral Health Services by the Adult Population: A Multi-level Analysis. *PLoS ONE* **2016**, 11, e0145149. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26730714/>. Acesso em: 29 Mar, 2024.

Rio da Ostras. *Dados Municipais*; Prefeitura Municipal de Rio das Ostras: Rio de Janeiro, Brasil, 2024. Disponível em: <https://www.riodasostras.rj.gov.br/dados-municipais/#:~:text=O%20resultado%20do%20Censo%202022,foi%20de%2048%2C09%25>. Acesso em: 29 Mar, 2024.

Samuelson-Kiraly, C.; Montague, T.; Nemis-White, J.; MacPherson, N.; Martin, L.; Aylen, J.; Gogovor, A.; Mitchell, J.I. Access and quality of health care in Canada: Insights from 1998 to the presents. *Healthc Manage Forum*. 2020, *33*, 6, 253-258.

SEIXAS, C. T. et al. O vínculo como potência para a produção do cuidado em Saúde: o que usuários-guia nos ensinam. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v. 23, 2019.

Senn, N.; Breton, M.; Ebert, S.T.; Lamoureux-Lamarche, C.; Lévesque, J.F. Assessing primary care organization and performance: Literature synthesis and proposition of a consolidated framework. Health Policy **2021**, *125*, 160–167.

Simão, C.C.A.L.; Costa, M.B.; Colugnati, F.A.B.; de Paula, E.A.; Vanelli, C.P.; de Paula, R.B. Quality of Care of Patients with Diabetes in Primary Health Services in Southeast Brazil. J. Environ. Public Health **2017**, 2017, e1709807. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5654281/pdf/JEPH2017-1709807.pdf>. Acesso em: 29 Mar, 2024.

Soeiro, O.M.; Tavares, N.U.L.; Do Nascimento Júnior, J.M.; Guerra Junior, A.A.; Costa, E.A.; de Assis Acurcio, F.; Guibu, I.A.; Álvares, J.; de Oliveira Karnikowski, M.G.; Leite, S.N.; et al. Patient satisfaction with pharmaceutical services in Brazilian primary health care. Rev. *Saúde Pú-Blica (Online)* **2017**, *51*, 1S–11S.

Souza, E.C.F.D.; de Vilar, R.L.A.; De Sá Pinto Dantas Rocha, N.; da Costa Uchôa, S.A.; de Medeiros Rocha, P. Acesso e acolhimento na atenção básica: Uma análise da percepção dos usuários e profissionais de saúde. *Cad. Saúde Pública Rio Jan.* **2008**, *24* (Suppl. 1), s100–s110.

Stopa, S.R.; Malta, D.C.; Monteiro, C.N.; Szwarcwald, C.L.; Goldbaum, M.; Cesar, C.L.G. Use of and access to health services in Brazil, 2013 National Health Survey. Rev. *Saúde Pública* **2017**, *51* (Suppl. 1), 3s.

Starfield, B.; Shi, L.; Macinko, J. Contribution of Primary Care to Health Systems and Health. *Milbank Q.* **2005**, *83*, 457–502.

The Commonwealth Fund. Mirror, Mirror 2021: Reflecting Poorly. Disponível em: <https://www.commonwealthfund.org/publications/fund-reports/2021/aug/mirror-mirror-2021-reflecting-poorly>. Acesso em: 22 Jan, 2024.

TÔRRES, L.L.; Azevedo, P.S.; Rocha Sarmento, T.T.; Ramalho-de-Oliveira, D.; Reis, E.A.; Dias Godói, I.P.; Guerra Júnior, A.A.; Ruas, C.M. Acceptability and consumers' willingness to pay for comprehensive medication management services in Brazil. J. Comp. Eff. Res. **2024**, *13*, e230127.

VILARINS, G. C. M.; PINHO, D. L. M. Aplicação do mapeamento conceitual na regulação do acesso aos serviços públicos de saúde, Distrito Federal, Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 26, n. 11, p. 5829–5840, nov. 2021. Disponível em: < https://www.scielo.br/j/csc/a/WJ9KwSsQXcvcRsvc864VBgb/?lang=pt>. Acesso em: 29 Mar, 2024.

WHO Library Cataloguing; World Health Organization. Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030; WHO: Geneva, Switzerland, 2016. Disponível em: < https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/250368/9789241511131-eng.pdf>. Acesso em : 29 Mar, 2024.

WHO Library Cataloguing; World Health Organization. Monitoring the Building Blocks of Health Systems: A Handbook of Indicators and Their Measurement Strategies; WHO: Geneva, Switzerland, 2010. Disponível em: < https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/258734/9789241564052-eng.pdf>. Acesso em : 10 Jan,2024.

World Health Organization; Organization for Economic Co-operation and Development & International Bank for Reconstruction and Development. *Delivering Quality Health Services: A Global Imperative for Universal Health Coverage*; World Health Organization: Geneva, Switzerland, 2018. Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/272465>. Acesso em: 10 Jan, 2024.

9. APÊNDICE

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Data: ____ / ____/ _____

Questionário nº : _____

Entrevistador: _____

PESQUISA SOBRE AVALIAÇÃO DO ACESSO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS EM SAÚDE

Q01- REGIÃO: 1. [ ] Metropolitana 2. [ ] dos Lagos 3. [ ] Serrana 4. [ ] Norte Fluminense

Q02- SEXO: 1. [ ] Masculino 2. [ ] Feminino 3. [ ] Outro 4. [ ] Não sabe 5. [ ] Não respondeu

Q03- IDADE (anos): ___ anos

Q04- ESTADO CIVIL:
1. [ ] Solteiro(a) 2. [ ] Casado(a) 3. [ ] Viúvo(a)
4. [ ] União estável (amigado) 5. [ ] Divorciado(a) ou separado(a) judicialmente
6. [ ] Outro 7. [ ] Não sabe 8. [ ] Não respondeu

Q05- COR DA PELE:
1. [ ] Branca 2. [ ] Preta 3. [ ] Parda (morena, mulata, cabocla cafuza, mameluca, mestiça)
3. [ ] Indígena 4. [ ] Quilombola 5. [ ] Amarela (japonesa, chinesa, coreana)
6. [ ] Outra 7. [ ] Não sabe 8. [ ] Não respondeu

Q06- ESCOLARIDADE:
01. [ ] Analfabeto
10. [ ] Ensino fundamental Incompleto (1o grau)
11. [ ] Ensino fundamental Completo 1o grau)
20. [ ] Ensino médio Incompleto (2o grau)
21. [ ] Ensino médio Completo (2o grau)
30. [ ] Ensino superior Incompleto (graduação)
31. [ ] Ensino superior Completo (graduação)
40. [ ] Pós-graduação lato sensu (Especialização, MBA)
50. [ ] Mestrado
60. [ ] Doutorado
88. [ ] Não sabe
99. [ ] Não respondeu

Q07- RENDA TOTAL NO DOMICÍLIO:
Juntando a renda de todos os moradores de sua residência, qual seria o valor total?
1. [ ] Até 1 salário mínimo (≤R$ 1320,00)
2. [ ] 1-2 salários mínimos (R$ 1320,01 a R$ 2640,00)
3. [ ] 2-3 salários mínimos (R$ 2640,01 a R$ 3960,00)
4. [ ] 3-5 salários mínimos (R$ 3960,01 a R$ 6600,00)
5. [ ] 5-10 salários-mínimos (R$ 6600,01 a R$ 13200,00)
6. [ ] 10-20 salários mínimos (R$ 13200,01 a R$ 26400,00)
7. [ ] Mais de 20 salários mínimos (≥R$ 26.400,01)
8. [ ] Não sabe
9. [ ] Não respondeu

Q08- NÚMERO DE PESSOAS NO DOMICÍLIO? 1. [ ] Um 2. [ ] Dois 3. [ ] Três 4. [ ] Quatro ou mais

Q09- VOCÊ TEM PLANO DE SAÚDE? 1. [ ] Sim 2. [ ] Não 8. [ ] Não sei 9. [ ] Não respondeu

Q10- VOCÊ UTILIZA OS SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE? 1. [ ] Sim 2. [ ] Não 8. [ ] Não sei 9. [ ] Não respondeu

CONDIÇÕES CLÍNICAS:

Alguma vez na vida um médico ou outro profissional de saúde disse que você tem ou teve as seguintes doenças?

Q101- Hipertensão: 1.[ ] Sim 2. [ ] Não 8. [ ] Não sei
Q102- Diabetes Mellitus: 1.[ ] Sim 2. [ ] Não 8. [ ] Não sei
Q103- Doenças do coração: 1.[ ] Sim 2. [ ] Não 8. [ ] Não sei
Q104- Ansiedade ou depressão: 1.[ ] Sim 2. [ ] Não 8. [ ] Não sei
Q105- Artrite, artrose, reumatismo: 1.[ ] Sim 2. [ ] Não 8. [ ] Não sei
Q106- AVC (acidente vascular cerebral ou "derrame"): 1. [ ] Sim 2. [ ] Não 8. [ ] Não sei
Q107- Dislipidemia (colesterol alto e/ou triglicerídeos alto): 1. [ ] Sim 2. [ ] Não 8. [ ] Não sei
Q108- Doença pulmonar crônica (asma, bronquite, enfisema, outra): 1. [ ] Sim 2. [ ] Não 8. [ ] Não sei
Q109- Outra(s) doença(s) com MAIS DE SEIS MESES de duração: 1. [ ] Sim 2. [ ] Não Qual(is)?_____

UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Q201A- Você utiliza remédios COM RECEITA MÉDICA? 1. [ ] Sim 2. [ ] Não 3. [ ] Não sei
Q201B- Quantos? 1. [ ] Um 2. [ ] Dois 3. [ ] Três 4. [ ] Quatro ou mais 88. [ ] Não sei 99. [ ] Não se aplica

Q302A- Você utiliza remédios SEM RECEITA MÉDICA? 1. [ ] Sim 2. [ ] Não 3. [ ] Não sei
Q302B- Quantos? 1. [ ] Um 2. [ ] Dois 3. [ ] Três 4. [ ] Quatro ou mais 88. [ ] Não sei 99. [ ] Não se aplica

Q302C- Em quais casos você utiliza algum remédio SEM RECEITA? (Pode marcar mais de uma opção)
1. [ ] Quando tem o remédio em casa.
2. [ ] Quando já tomou este remédio antes.
3. [ ] Quando conhece alguém que já tomou e indicou.
4. [ ] Quando consegue o remédio fácil.
5. [ ] Quando recebe indicação na farmácia.
6. [ ] Quando leu a bula ou outra fonte de informação (internet/rede social).
7. [ ] Outro:_____
_____
8. [ ] Não sei 9. [ ] Não se aplica

Q401- Você confia nos remédios que utiliza?
1. [ ] Sempre 2. [ ] Na maioria das vezes 3. [ ] Poucas vezes 4. [ ] Nunca 8. [ ] Não sei

Q402- Você recebe orientações médicas dos remédios prescritos?
1. [ ] Sempre 2. [ ] Na maioria das vezes 3. [ ] Poucas vezes 4. [ ] Nunca 8. [ ] Não sei

Q403- Como você considera a orientação médica que recebe sobre os remédios prescritos:
1. [ ] Fácil compreensão 2. [ ] Confusa 3. [ ] Difícil 4. [ ] Não recebo orientação 8. [ ] Não sei 9. [ ] Não respondeu

Q404- Você recebe orientações do farmacêutico sobre os remédios que utiliza?
1. [ ] Sempre 2. [ ] Na maioria das vezes 3. [ ] Poucas vezes 4. [ ] Nunca 8. [ ] Não sei 9. [ ] Não respondeu

Q405- Como você considera a orientação farmacêutica que recebe sobre os remédios que utiliza:
1. [ ] Fácil compreensão 2. [ ] Confusa 3. [ ] Difícil 4. [ ] Não recebo orientação 8. [ ] Não sei 9. [ ] Não respondeu

Q406- Vou dizer alguns tipos de dificuldades comuns que as pessoas enfrentam ao lidar com medicamento. Responda se você enfrenta cada dificuldade que eu vou falar:
[Marque todas as opções que o respondente disser SIM e perguntar "Alguma outra?"]
1. [ ] Conseguir os remédios.
2. [ ] Lembrar os horários de tomar o remédio.
3. [ ] Utilizar muitos remédios ao dia.
4. [ ] Ler o que está escrito na embalagem.
5. [ ] Adequar a utilização do remédio com o horário do trabalho.
6. [ ] Confundir remédios com a mesma aparência.
7. [ ] O não uso de bebida alcoólica durante o uso de algum remédio
7. [ ] Outra: _____
_____
0. [ ] Nenhuma.
88. [ ] Não sabe.
99. [ ] Não respondeu.

PERCEPÇÕES E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE PÚBLICA

Q501- Você utiliza os serviços públicos em saúde (SUS)?
1.[ ] Sempre 2.[ ] Frequentemente 3.[ ] Às vezes 4.[ ] Raramente 5.[ ] Nunca 8.[ ] Não sei 9.[ ] Não quis responder

Q502- Quais os serviços você utiliza ou já utilizou do SUS?
1.[ ] Consulta médica 2.[ ] Consulta odontológica 3.[ ] Vacinação 4.[ ] Realização de Cirurgia 5.[ ] Aquisição de Medicamento 6.[ ] Transplante de órgão 7.[ ] Vários serviços 8.[ ] Pré Natal/Preventivo 9. [ ] Nenhum 10.[ ] Não sabe 11.[ ] Não quis responder

- **Se respondeu que NUNCA USOU (Q501) E NÃO USOU NENHUM SERVIÇO DO SUS (Q502), agradeça a participação e encerre a entrevista.**
- **Se respondeu quaisquer um dos demais itens das questões anteriores, continue a seguir.**

Q503- Para você o Sistema Único de Saúde é:
1.[ ] Indispensável/Essencial 2.[ ] Complementar a rede privada 3.[ ] Indiferente 4.[ ] Desnecessário 8. [ ] Não sei 9.[ ] Não quis responder

Q504- Você conhece algum programa ou iniciativa do SUS é:
1.[ ] Sim 2.[ ] Não 3.[ ] Não Sabe 4.[ ] Não quis responder

Q505- Você é cadastrado em alguma Unidade de Saúde e/ou Estratégia Saúde da Família do Município?
1.[ ] Sim 2.[ ] Não 8.[ ] Não sabe 9.[ ] Não quis responder

Q506- Você retira medicamentos em alguma unidade de saúde pública que é cadastrado
1.[ ] Sim 2.[ ] Não 8.[ ] Não sabe 9.[ ] Não quis responder

Q507- Qual sua opinião sobre a realização deste tipo de serviço a ser realizado pelas UBS e/ou ESF?
1.[ ] Muito bom 2.[ ] Bom 3.[ ] Nem bom, nem ruim 4.[ ] Ruim 5.[ ] Muito ruim 8.[ ] Não sei 9.[ ] Não quis responder

Q508- Suas consultas médicas são realizadas:
1.[ ] Somente no SUS 2.[ ] Somente pelo Plano de Saúde 3.[ ] SUS e Plano de Saúde 8.[ ] Não sabe 9.[ ] Não quis responder

Q509- Você considera o processo para marcação de consultas médica com clínico geral pelo SUS:
1.[ ] Muito bom 2.[ ] Bom 3.[ ] Nem bom, nem ruim 4.[ ] Ruim 5.[ ] Muito ruim 8.[ ] Não sei 9.[ ] Não quis responder

Q510- Você considera o processo para marcação de consultas com especialistas (oftalmologista/cardiologista) pelo SUS:
1.[ ] Muito bom 2.[ ] Bom 3.[ ] Nem bom, nem ruim 4.[ ] Ruim 5.[ ] Muito ruim 8.[ ] Não sei 9.[ ] Não quis responder

Q511- Você considera o atendimento médico ofertado pelo SUS como:
1.[ ] Muito bom 2.[ ] Bom 3.[ ] Nem bom, nem ruim 4.[ ] Ruim 5.[ ] Muito ruim 8.[ ] Não sei 9.[ ] Não quis responder

Q512- Você considera o acesso aos serviços públicos de saúde como:
1.[ ] Muito bom 2.[ ] Bom 3.[ ] Nem bom, nem ruim 4.[ ] Ruim 5.[ ] Muito ruim 8.[ ] Não sei 9.[ ] Não quis responder

Q513- Um dos objetivos do nosso estudo é avaliar a percepção do cidadão sobre acesso à saúde que significa "a capacidade do sistema de saúde em prover o cuidado e o serviço necessários, no momento certo e no lugar ". Como você avalia o acesso dos serviços em saúde oferecidos pelo SUS:
1.[ ] Muito bom 2.[ ] Bom 3.[ ] Nem bom, nem ruim 4.[ ] Ruim 5.[ ] Muito ruim 8.[ ] Não sei 9.[ ] Não quis responder

Q514- Você não foi atendido e/ou não consegui acesso à algum tipo de serviço no SUS, nos últimos dois anos:
1.[ ] Sim 2.[ ] Não 8.[ ] Não sabe 9.[ ] Não quis responder
Se sim, qual tipo de serviço?_____

Q515- Para você o que é o mais importante associado à qualidade dos serviços de saúde:

1.[ ] Agilidade no agendamento do atendimento 2.[ ] Facilidade geográfica do local a ser realizado o serviço 3. [ ] Agilidade no atendimento. 4.[ ] Acolhimento cordial dos profissionais 4.[ ] Ambiência satisfatória (estrutura física, conforto, limpeza, acessibilidade) 5.[ ] Atendimento humanizado 8.[ ] Não sei 9.[ ] Não quis responder

Q516- Na sua opinião, qual o fator mais importante a ser melhorado referente aos serviços públicos de saúde:

1.[ ] Infraestrutura 2.[ ] Qualificação dos profissionais 3.[ ] Maior Facilidade no acesso à medicamentos 4.[ ] Ampliação do número de unidades de serviços em saúde (UBS/ESF/Hospitais) 5. [ ] Ampliação dos serviços ofertados (ex: aumento do número de consultas) 6. [ ] Maior facilidade no acesso à medicamentos 8.[ ] Não sei 9.[ ] Não quis responder 10.[ ] Outro:_____

Q517- Como você avalia a qualidade dos serviços em saúde oferecidos pelo SUS:
1.[ ] Muito bom 2.[ ] Bom 3.[ ] Nem bom, nem ruim 4.[ ] Ruim 5.[ ] Muito ruim 8.[ ] Não sei 9.[ ] Não quis responder

Q518- Você já teve que utilizar os serviços do SUS em outro município diferente ao seu?
1.[ ] Sempre 2.[ ] Frequentemente 3.[ ] Às vezes 4.[ ] Raramente 5.[ ] Nunca 6.[ ] Não sei 7.[ ] Não quis responder

Q519- Se sim, qual? 1.[ ] Consulta clínica 2.[ ] Cirurgia 3.[ ] Consulta com especialista 4.[ ] Não sei 7.[ ] Não quis responder

Q520- Como você adquire seus remédios?
1.[ ] Apenas de forma particular (compra em drogarias/farmácias privadas).
2.[ ] Apenas de forma gratuita em FARMÁCIAS PÚBLICAS DO SUS.
3.[ ] Tanto de forma gratuita como de forma particular.
4.[ ] Doação de amigos/familiares. 8.[ ] Não sei 9.[ ] Não quis responder

- **Se respondeu que adquire apenas de forma particular, agradeça a participação e encerre a entrevista.**

Q521- Este lugar é longe da sua casa?
1.Sim [_] 2.Mais ou menos [_] 3.Não [_] 8.Não Sei [_]

Q522- Como você chega até o local para adquirir seu remédio pelo SUS? *[Pode assinalar mais de uma opção.]*
1.[ ] Caminhando 2.[ ] Ônibus e/ou transporte coletivo
3.[ ] Carro 4.[ ] Moto 5.[ ] Bicicleta
6.[ ] Outro:_____
8.[ ] Não sei 9.[ ] Não quis responder

Q523- Os funcionários das FARMÁCIAS PÚBLICAS DO SUS onde você retira os remédios atendem com respeito e cortesia?
1.[ ] Sempre 2.[ ] Frequentemente 3.[ ] Às vezes
4.[ ] Raramente 5.[ ] Nunca 8.[ ] NS 9.[ ] NR

Q524- A FARMÁCIA PÚBLICA DO SUS na qual você busca seus remédios é um ambiente limpo e organizado?
1.[ ] Sempre 2.[ ] Frequentemente 3.[ ] Às vezes
4.[ ] Raramente 5.[ ] Nunca 8.[ ] NS 9.[ ] NR

Q525- O horário de funcionamento da FARMÁCIAS PÚBLICAS DO SUS em que busca os remédios é:
1.[ ] Muito bom 2.[ ] Bom 3.[ ] Nem bom, nem ruim
4.[ ] Ruim 5.[ ] Muito ruim 8.[ ] NS 9.[ ] NR

Q526- Nos últimos três meses, você PROCUROU por algum remédio em FARMÁCIAS PÚBLICAS DO SUS?
1.[ ] Sempre 2.[ ] Frequentemente 3.[ ] Às vezes
4.[ ] Raramente 5.[ ] Nunca 8.[ ] NS 9.[ ] NR

Q527- Nestes três últimos meses, com qual frequência você CONSEGUIU os remédios que procurava FARMÁCIAS PÚBLICAS DO SUS?
1.[ ] Sempre 2.[ ] Frequentemente 3.[ ] Às vezes
4.[ ] Raramente 5.[ ] Nunca 8.[ ] NS 9.[ ] NR

Q528- Normalmente, quanto tempo você espera para retirar os remédios nas farmácias ?
1.[ ] No mesmo dia 2.[ ] No dia seguinte 3.[ ] Três dias depois 4.[ ] Uma semana depois
5.[ ] 15 dias depois 6.[ ] Mais de 15 dias depois 7.[ ] Outro:_____ 8.[ ] Não sei 9.[ ] NR

Q529- Quando você retira remédios nas FARMÁCIAS PÚBLICAS DO SUS, os funcionários que entregam os remédios repassam informações e/ou orientações sobre como usá-los?
1.[ ] Sempre 2.[ ] Frequentemente 3.[ ] Às vezes
4.[ ] Raramente 5.[ ] Nunca 8.[ ] NS 9.[ ] NR

Q530- Quando retira remédios nas farmácias públicas do SUS, você recebe orientação sobre como guardar os remédios em casa?
1.[ ] Sempre 2.[ ] Frequentemente 3.[ ] Às vezes
4.[ ] Raramente 5.[ ] Nunca 8.[ ] NS 9.[ ] NR

Q531 - O farmacêutico ou outro funcionário das FARMÁCIAS PÚBLICAS DO SUS está disponível quando você precisa tirar dúvidas sobre os remédios?
1.[ ] Sempre 2.[ ] Frequentemente 3.[ ] Às vezes
4.[ ] Raramente 5.[ ] Nunca 8.[ ] Não sei 9.[ ] Não quis responder

Q532 - Você já encontrou o profissional farmacêutico na unidade pública que frequenta (ESF, UBS, dispensação de medicamentos)?
1.[ ] Sempre 2.[ ] Frequentemente 3.[ ] Às vezes
4.[ ] Raramente 5.[ ] Nunca 6.[ ] Não sei 7.[ ] NR

Q533 - Se sim, você sabe quais são os serviços prestados pelo profissional farmacêutico?
1.Sim [_] 2.Mais ou menos [_] 3.Não [_] 4.Não Sei [_]

Q534 - No seu município, há farmacêutico em Unidade Básica de Saúde e/ou ESF?
1.[ ] Sim 2.[ ] Não 8.[ ] Não sei 9.[ ] Não quis responder

Q535 - Como você avalia o papel do farmacêutico no processo de orientação sobre o uso de medicamentos:
1.[ ] Indispensável/Essencial 2.[ ] Indiferente 3.[ ] Desnecessário 8.[ ] Não sei/ Nunca recebi orientação de um farmacêutico 9.[ ] Não quis responder

Q536 - Na sua opinião, qual a principal contribuição do farmacêutico na Atenção Primária a Saúde?
1.[ ] Organização das demandas administrativas sobre medicamentos 2.[ ] Orientação/cuidado farmacêutico sobre uso dos medicamentos 3.[ ] Contribuir para as ações e atividades em saúde de uma equipe multidisciplinar 8.[ ] Não sei 9.[ ] Não quis responder

EM NOME DE TODA EQUIPE DESTE ESTUDO, AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO E DISPONIBILIDADE

International Journal of Environmental Research and Public Health

MDPI

Article

Users' Perceptions of Access to and Quality of Unified Health System Services in Brazil: A Cross-Sectional Study and Implications to Healthcare Management Challenges

Jhoyce S. Souza [1], Edna A. Reis [2], Brian Godman [3,4], Stephen M. Campbell[4,5], Johanna C. Meyer [4], Luann W. P. Sena[6] and Isabella P. D. Godói [1,7]*

[1] Institute of Pharmaceutical Sciences, Federal University of Rio de Janeiro, Avenida Aluízio da Silva Gomes, 50—Granja dos Cavaleiros, Macaé, Rio de Janeiro 27930-560, Brazil; jhoyce.tcc.ufrj@gmail.com (J.S.S); isabellapiassi@macae.ufrj.br (I.P.D.G)

[2] Department of Statistics, Exact Sciences Institute, Federal University of Minas Gerais, Avenida Antônio Carlos, 6627, Campus Pampulha, Belo Horizonte 31270-901, Minas Gerais, Brazil; ednareis@gmail.com

[3] Strathclyde Institute of Pharmacy and Biomedical Sciences, University of Strathclyde, Glasgow, G4 0RE, UK; brian.godman@strath.ac.uk

[4] Department of Public Health and Pharmacy Management, School of Pharmacy, Sefako Makgatho Health Sciences University, Ga-Rankuwa, Pretoria 0208, South Africa; brian.godman@smu.ac.za (B.G);stephen.campbell@smu.ac.za (S.M.C.); hannelie.meyer@smu.ac.za (J.C.M.)

[5] School of Health Sciences, University of Manchester, Manchester M13 9PL, UK; stephen.campbell@manchester.ac.uk

[6] College of Public Health, Institute of Health and Biological Studies, Federal University of South and Southeast of Pará, Marabá, Avenida dos Ipês, s/n, Cidade Universitária, Loteamento Cidade Jardim, Pará 68508-970, Brazil; luannsena@unifesspa.edu.br

[7] Health Technology Assessment Center—Management, Economics, Health Education and Pharmaceutical Services (GEESFAR/NATS/UFRJ), Federal University of Rio de Janeiro, Avenida Aluízio da Silva Gomes, 50—Granja dos Cavaleiros, Macaé, Rio de Janeiro 27930-560, Brazil; isabellapiassi@gmail.com

* Correspondence: isabellapiassi@macae.ufrj.br or isabellapiassi@gmail.com

Citation: Souza, J.S.; Reis, E.A.; Godman, B.; Campbell, S.M.; Meyer, J.C.; Sena, L.W.P.; Godói, I.P.D. Users' Perceptions of Access to and Quality of Unified Health System Services in Brazil: A Cross-Sectional Study and Implications to Healthcare Management Challenges. Int. J. Environ. Res. Public Health 2024, 21, 721. https://doi.org/10.3390/ijerph21060721

Academic Editor (s) : Ilaria Tocco Tussardi and Paul B. Tchounwou

Received: 31 March 2024
Revised: 24 May 2024
Accepted: 29 May
Published: 31 May 2024

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CCBY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: Evaluating the access to and quality of healthcare services from the users' perspective is an important assessment process to identify priorities. This study assessed the profile of health service usage and the views of the Unified Health System (SUS) users about the access to and quality of SUS public health services. A cross-sectional study was conducted with participants from the Coastal Lowlands Region of the Rio de Janeiro State/Brazil, between August and November 2023. The association between categorical variables was analyzed using the Pearson Chi-Square test, using R software 4.3. A total of 200 individuals were interviewed using a 66-question survey instrument. Participants who reported using SUS services more frequently rated this system as essential (p-value = 0.031). However, overall, 64% of participants rated the quality of care to be *very bad/bad and 34.9% rated access as very bad/bad. Access was considered poor by respondents who used public services rarely or sometim*es (p-value = 0.002). In terms of accessing SUS services consultations provided by specialists (e.g., neurologists), these were available only in another municipality (p-value = 0.001). Many participants were SUS dependent for health services, and gaps and weaknesses were observed regarding users' perspectives of the access to and quality of SUS health care. Policymakers should prioritize evaluations and dialogue with the community to make SUS services responsive and to optimize value-for-money in health service planning.

Keywords: Brazil; access; quality; health services; experiences; users; public health; management

1. Introduction

In Brazil, free access to health services for the population in the country became a right of citizenship from the Federal Constitution of 1988, in article 196 [1]. The regulation of the Brazilian public health system occurred with the Laws n° 8080 [2] and n° 8142 [3] of 1990, which established a universal health system based on key principles including completeness, decentralization, and hierarchical and social participation [2–5]. According to Castro and collaborators (2019), the trajectory of the development and expansion of the Unified Health System (SUS) has faced many challenges in fulfilling its constitutional mandate of providing 'health for all' in a highly unequal country with relatively low resources and highlighted the importance of community participation [6,7].

The SUS organizes and provides health services and actions at different levels in Brazil, including primary, secondary, and tertiary care [6]. Evidence suggests that primary care-led health care systems increase the responsiveness and capacity to address issues locally [8,9] and enable greater capacity to address the World Health Organization (WHO) Sustainable Development Goals (SDGs) and Universal Health Coverage (UHC). The joint WHO/World Bank/OECD 2018 report stated: "accessible and high-quality primary care should be the bedrock for all other services" [10] and advocated a focus on seven domains of quality of care. These were effectiveness, safety, people-centeredness, timeliness, integration of care, equity, and efficiency. According to the Ministry of Health in Brazil, the majority of health demands can be addressed in primary care [2], which emphasizes its importance to health systems as the main entry point for patients to the SUS in Brazil [11–13].

Over the past few years, many projects and strategies have been promoted by the Ministry of Health in Brazil aimed at the primary health care level, including the National Immunization Program (PNI, in Portuguese), which has guaranteed the provision of vaccines to the population since its establishment in 1973 [14,15]. The PNI, as part of the SUS, provides fifteen vaccines to children, nine to adolescents, and five to adults and the elderly, free of charge, from Basic Health Units and Family Health Strategies, protecting the population against more than 20 diseases. Morbidity and mortality have been reduced due to this public health strategy, with a focus on prevention, and key program of the SUS, as it significantly contributed to the control of various vaccine-preventable diseases [14]. These include the eradication of smallpox in 1973, the elimination of rubella and congenital rubella in 2015, measles in 2016, and neonatal tetanus in 2020 [15].

During the COVID-19 pandemic, the PNI facilitated collective immunization against SARS-CoV-2, following the introduction of effective vaccines across different age groups [14,16]. The Brazilian government financed the purchase of vaccines. Up until March 2024, a total of 553,562,962 doses have been administered in the country against SARS-CoV-2 since the start of the vaccinations [16]. The COVID-19 immunization services were delivered by Primary Health Care and reinforced the PNI as one of the most important health programs in Brazil, included in the SUS.

The SUS provides a network of services to over 203 million inhabitants, distributed among over 5500 municipalities (26 States and the Federal District) throughout the country, of which approximately 70% have populations of between 10 and 20 thousand inhabitants [17]. The importance of local collaboration and partnership enables the provision of responsive health services to their respective populations, given the numerous limitations and challenges in logistics and infrastructure, as well as the cultural and socioeconomic issues faced in health care delivery by each locality [6,7]. Consequently, it is relevant to conduct studies involving local, regional, or national interventions, in order to better evaluate the perception of users in terms of access to and quality of SUS health care in Brazil.

Alongside SUS services, the Brazilian private market for health insurance is regulated by the National Regulatory Agency for Private Health Insurance and Plans, which works on behalf of the Ministry of Health [18]. Private health insurance can either be purchased individually or obtained as a work benefit, depending on the employer. Individuals who decide to purchase private health insurance may still access public health care [19]. According to National Regulatory Agency for Private Health Insurance and Plans, 51,035,365

individuals have private health insurance (March 2024) in the country, approximately 25% of the population [20].

The timely access to health care services is a crucial component of, and a prerequisite for, delivering quality of care [21,22]. There have been some studies published regarding Brazil in relation to the management of public health services at the federal, state, and municipal levels [23–25]; the quality of health services [12,26–29]; and about pharmaceutical public services [30–33].

The concept of access is broad and requires a multidimensional understanding with political, socioeconomic, technical, and organizational aspects, with the goal of enabling users to use health services to meet their needs [34]. It is important to differentiate between the terms access, accessibility, and availability and to differentiate between timely access to health services and physical access to services. Indeed, access involves key aspects such as geographic dimensions, economy, culture, and services offered [35]. Given that Brazil is a country with many local and regional particularities inside and outside the health scenario, it is relevant to evaluate the contexts of the health service in terms of the access and quality of services offered from the SUS user's perspective in different localities.

According to the WHO's 2016 publication "*Global strategy on human resources for health: Workforce 2030*", in the Western Pacific Regional Office, the UHC is part of a broader concept of universal access to health care, highlighting the need to achieve improvements in the access, acceptability, and quality of health services [36]. Quality primary care services improve population and individual health outcomes, contribute to the reduction in public health costs, achieve a greater efficiency of care, and enable the identification of quality deficits in health care services such as waiting times or unavailability of health professionals or services [37–40]. Identifying and improving deficiencies will be a key focus for future programs.

The present study aimed to ascertain the perceptions and experiences of individuals from the Coastal Lowlands, in the Rio de Janeiro State, regarding the access to and quality of services offered by the SUS, as well the profile of use of health services in this region in Brazil. Understanding SUS users' perceptions and needs is essential for the monitoring and assessment of public health systems and for assisting with the future planning and management of health services in this region.

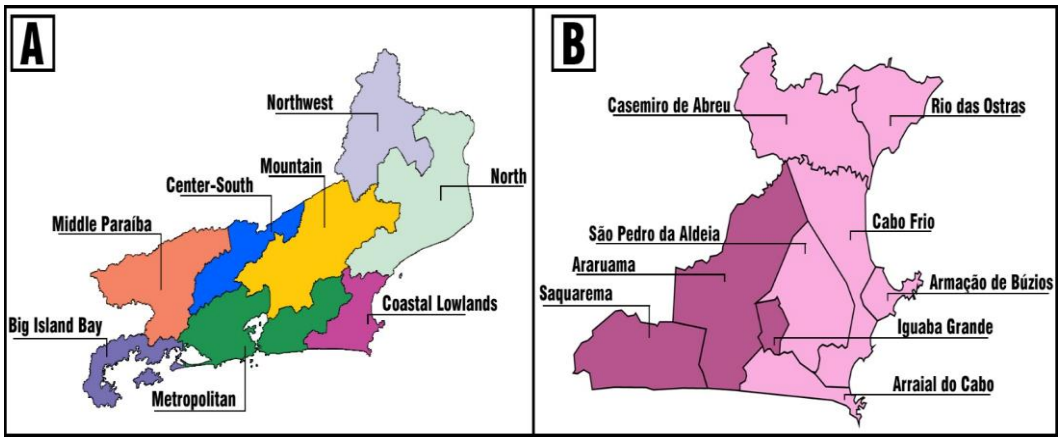
2. Methods

2.1. Study Design and Setting

A cross-sectional study was conducted to assess the views of individuals in the Coastal Lowlands of Rio de Janeiro State, regarding the access to and quality of SUS health services. This study was conducted in two steps—Step One: descriptive questions and analysis including all participants (n = 200) related to general aspects of health services and the sample characteristics (e.g., gender, age, education, and family income); Step Two: users' perceptions regarding the access to and the quality of the public health system/SUS.

Within Brazil, the Rio de Janeiro State is in the southeast region of the country, with approximately 16 million inhabitants [41], divided into eight regions, i.e., the Metropolitan, Medio Paraíba, Central-South Fluminense, Mountain, Coastal Lowlands, Fluminense North, Fluminense Northwest, and Big Island Bay, as presented in Figure 1A [42]. The Coastal Lowlands is one of the main regions of the State, containing nine municipalities, including Cabo Frio and Rio das Ostras, as illustrated in Figure 1B [43]. The population of the region of the study has grown significantly in recent years and has undergone many socioeconomic transformations, including direct and indirect resources derived from oil exploration and tourism [44]. These changes have contributed to an increase in the demands on health services, without an understanding of its residents' views about the public health care services offered. To the best of our knowledge, no study has evaluated user experience of the access to and quality of health services in this region.

Figure 1. (**A**) Rio de Janeiro State in Brazil. (**B**) Coastal Lowlands Region of Rio de Janeiro State.



Note: the municipalities involved in this study were highlighted in a light pink color (**B**).

This study included the six main municipalities of this region in terms of demographic and socioeconomic characteristics such as Rio das Ostras, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, São Pedro da Aldeia, Armação dos Búzios, and Arraial do Cabo, located between 135 and 170 km from the state capital (Rio de Janeiro) [45]. The municipality of Cabo Frio has 222,161 inhabitants and a GDP *per capita* of BRL 52,801.54 (USD 10,475.69) [46], while Rio das Ostras has 156,491 inhabitants and a GDP *per capita* of BRL 56,096.82 (USD 11.126,34) [47].

2.2. Survey Instrument and Pilot Study

The questionnaire was prepared with the participation of students from the UFRJ-Macaé Pharmacy Course IPDG. The majority of questions included in the questionnaire were obtained from previous projects of the Brazilian Ministry of Health [48,49]. Overall, an interviewer-administered questionnaire (Supplementary Material S1) was created from publications of the Ministry of Health, such as the National Survey on the Access, Utilization and Promotion of Rational Use of Medicines (PNAUM), and the National Program for Improving Access and Quality of Primary Care (PMAQ) [48,49]. The instrument contained 66 questions, organized into the following four sections: (A) Socioeconomic and Use of Health Services Profile; (B) Clinical Condition; (C) Medication Use; and (D) Perceptions and Use of Public Health Services. It should be reinforced that in the last section (D), only the participants who reported use of SUS services answered (Step Two: Assess the users ′perceptions regarding access to and the quality of SUS services) and the previous sections (A, B, and C) included all participants (n = 200) (Step One—Descriptive Analyses).

To enhance the robustness of the questionnaire, it was pre-tested with 30 individuals from the municipality of Macaé (Northern Fluminense Region) near to the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ-Macaé). Comments were included in the final questionnaire for the main study. The pre-testing confirmed that no questions needed to be changed.

2.3. Data Collection and Inclusion Criteria

Data collection was undertaken between August and November 2023 in the Coastal Lowlands Region, involving 6 municipalities, as described above. The sample size calculation followed the proportion of the respective regional population. This resulted in a final minimum sample of 200 participants, which ensured a maximum margin of error of 7% in the estimation of global percentages.

Individuals aged 18 years or older (legal majority in Brazil) were recruited by convenience sampling, allowing the researchers to obtain a range of attitudes and opinions [50]. Participants who declared that they never used SUS services were asked questions in Step One (sections A, B, and C). Participants that reported using SUS services were asked questions in both Step One (Sections A, B, and C) and Step Two (section D), which related to users' perceptions about the access to and quality of SUS services.

In addition, individuals who reported only purchasing medicines in private pharmacies were also excluded from Step Two, which involved questions regarding pharmaceutical services in the public health system.

Data collection was conducted by five undergraduate students from the School of Pharmaceutical Sciences at the Federal University of Rio de Janeiro/Macaé who had been trained by one of the investigators (IPDG). The survey questions were administered in an interview, which was conducted in Portuguese in public spaces including public markets, squares, and avenues. Participants were invited to take part in the research on a voluntary basis and the objectives of the research were explained. Participants who agreed to participate in the research were asked to read and sign two copies of a consent form, one for the participant and one for the researcher.

2.4. Data Analysis

Analyses were conducted using the Microsoft Excel 2019 and R software version 4.3.0. Step One consisted of a descriptive analysis of responses from all participants (n = 200) relating to the use of SUS public health services including primary care, pharmacy, and specialist services and the sample characteristics, e.g., gender, age, education, and family income. Step Two focused on assessing users' perceptions of the access to and the quality of the SUS public health system excluding individuals who declared never using SUS services (primary care or pharmacy or specialist services) in Step One. In Step Two, questions related to use of pharmacies and included users' experiences of receiving guidance on the use of medicines and the role and presence of a pharmacist.

In addition, we assessed users' experiences of obtaining and using both over-the-counter (OTC) and prescribed medicines, as well as their adherence with taking prescribed medicines. Additionally, we evaluated their understanding of medicine information leaflets, including guidance on taking antibiotics and advice on the concomitant use of alcohol, as well as polypharmacy.

Categorical variables were described by absolute and relative frequencies. The association between categorical variables was analyzed using the Pearson Chi-Square test and was considered statistically significant when the p-value was < 0.05.

In addition, the conversion value provided by the Central Bank of Brazil (2023: USD 1, BRL 5.04) was adopted [51].

2.5. Ethical Aspects

This study was approved by the Research Ethics Committee of the Federal University of Rio de Janeiro/Macaé Campus (CAAE: 68864623.6.0000.5699).

3. Results

3.1. Population Characteristics

The data collection involved 200 participants from different locations and socioeconomic characteristics in the six localities of the Coastal Lowlands Region/Rio de Janeiro State. In Step One, 67% of respondents were female and 97.5% of individuals reported using SUS services (n = 195). The average age of the interviewees was 44 years (SD ± 13). In total, 64% of the respondents purchased their medicines privately only and 43.1% reported having purchased a medical prescription. Further details on the characteristics of the respondents are shown in Table 1.

Table 1. Characteristics of the respondents (n = 200).

Variable	n	(%) *
Female	134	67.0%
Male	66	33.0%
Age Profile (years old)		
18–25	21	10.5%
26–45	103	51.5%
46–60	54	27.0%
More than 60	22	11.0%
Race/skin color		
White	73	36.5%
Black	30	15.0%
Brown	94	47.0%
Other	3	1.5%
Education level		
Never attended school	2	1.0%
Incomplete elementary education	21	10.5%
Completed elementary school	14	7.0%
Incomplete high school	10	5.0%
Completed high school	54	27.0%
Incomplete college	36	18.0%
Completed college or more	63	31.5%
Family income * (number of times the minimum wage) **		
Up to 1	17	8.5%
1–2	46	23.0%
2–3	42	21.0%
3–5	51	25.5%
5–10	27	13.5%
10–20	3	1.5%
>20	2	1.0%
Use of SUS services—Yes	195	97.5%
Has a private health plan—Yes	95	47.5%

Notes: * Family income: Some respondents did not answer these questions ("don't know/don't want to answer"); ** Minimum wage in 2023: BRL 1320.00 [52].

Hypertension, anxiety, depression, diabetes mellitus, arthritis, and respiratory diseases were the most common self-reported conditions among participants, with 38% of the sample reporting two or more diseases and 23% of participants reporting no clinical conditions. The clinical profile of participants is shown in Table 2.

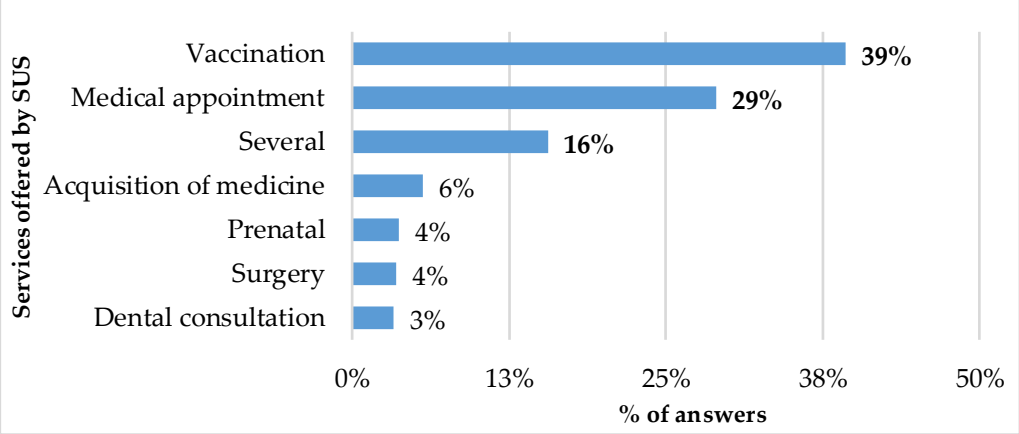
Table 2. Clinical profile of participants that reported their illnesses (n = 154).

Clinical Condition	%
Other respiratory diseases	26.2%
Anxiety/Depression	13.8%
Hypertension	12.4%
Other diseases	12.0%
Chronic Obstructive Pulmonary Disease	11.3%
Dyslipidemia	10.5%
Joint Disorders	7.7%
Diabetes Mellitus	3.1%
Other Cardiovascular problems	3.0%

Note: in total, 46 (23%) participants reporting no clinical conditions.

Among the individuals who declared using SUS services (n = 195), 128 (64%) reported purchasing medicines in private pharmacies, while 67 (36%) purchased medicines in public pharmacies. Respondents reported using SUS services mostly for vaccination (39%) and medical appointments (29%). See Figure 2 for further details.

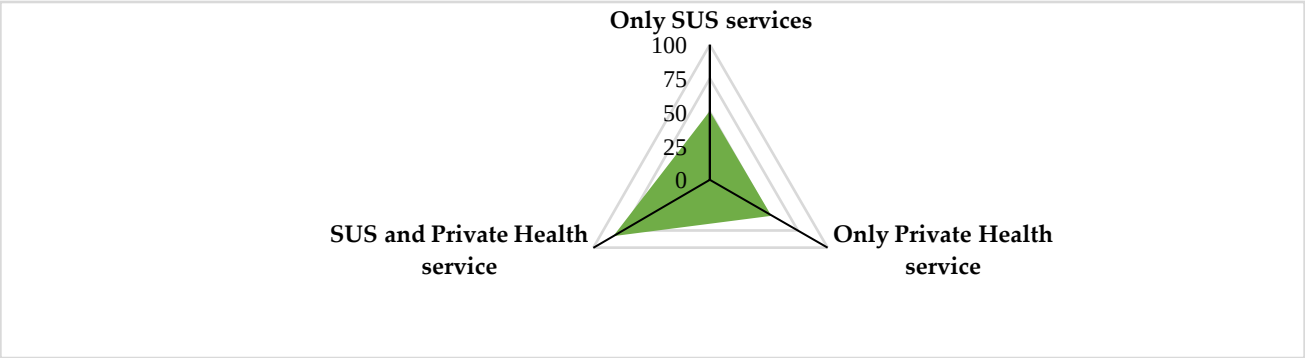
Figure 2. Profile of SUS services used by respondents (n = 200).



Note: respondents could record more than one service.

Overall, 42.1% of respondents declared using both the SUS and the private care (health plans or individually) for medical consultations, 26.4% used only private care, 26.0% used only SUS services, and 5.5% did not want to respond to this question (see Figure 3).

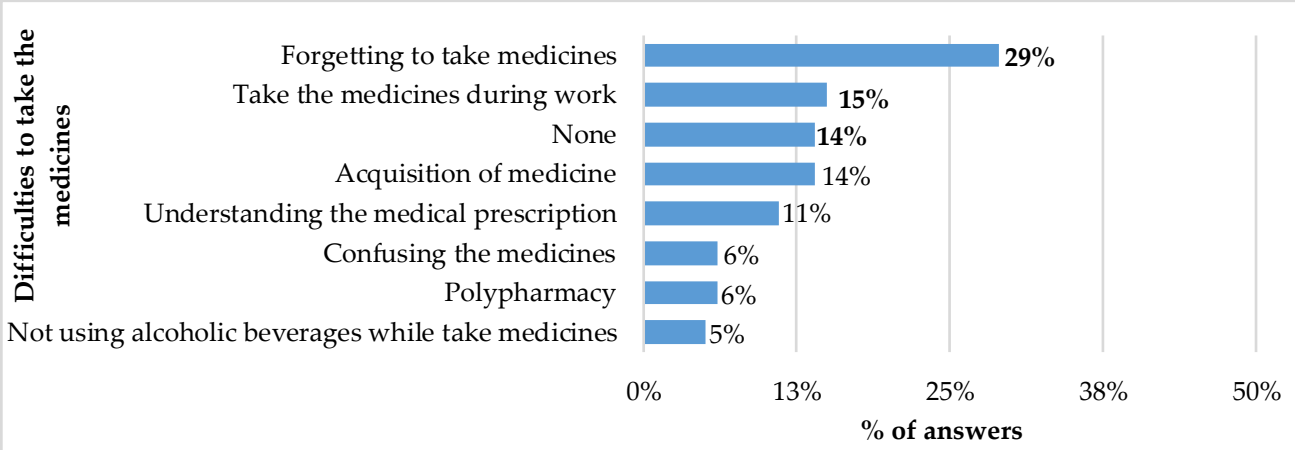
Figure 3. Profile of medical consultations used by the respondents (n = 195).



Note: a total of five participants did not want to respond to this question.

The majority (87.7%) of the respondents reported using OTC medicines without a prescription and also reported "using the medication as it is already at home". However, several difficulties were faced by the respondents regarding the use of medicines, including forgetting to take medicines (29%) and obtaining medicines from SUS services (14%), as presented in Figure 4.

Figure 4. Difficulties reported by respondents associated with the use of medicines (n=200).



Note: respondents could record more than one service.

Participants identified key priorities for improvement in SUS services, with 70.6% of respondents reporting issues related to patient safety, functionality, and comfort within SUS services. In addition, 12.1% of participants reported that there should be an increase in the number of SUS units to enhance accessibility, while 10.7% indicated that there should be an improvement in the ease of obtaining medications from the SUS public pharmacies.

3.2. Step Two: SUS Users' Perceptions Regarding Access to and Quality of Health Services

Of the 200 participants in the sample, as mentioned, 195 (97.5%) reported using the Brazilian SUS public health system. Participants who used public health services more frequently (*always* and/or *often*: n = 195) placed a greater importance on the SUS as being indispensable and essential to the population. Those who use them *sometimes* and/or *rarely* reported viewing the SUS as a complementary health system (p-value = 0.031), as presented in Table 3.

In general, access was considered poor for respondents who used public services *rarely* or *sometimes* (p-value = 0.002). Additionally, in a correlation analysis between the

variables of the quality of SUS services and the frequency of use of these services, those who use public health services more frequently tended to consider the quality of care as neither good nor bad (*p*-value = 0.000).

Table 3. Perceptions of SUS users regarding the relevance, access to, and quality of the public health services (n = 195).

Relevance of SUS n (%)

Frequency	Indispensable/Essential	Complementary	Indifferent	*p*-Value
Always	27 (81.8%)	3 (9.1%)	3 (9.1%)	
Frequently	37 (100.0%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	
Sometimes	74 (88.1%)	6 (7.1%)	4 (4.8%)	0.031
Rarely	34 (82.9%)	7 (17.1%)	0 (0.00%)	
ALL	172 (88.2%)	16 (8.2%)	7 (3.6%)	

Access to SUS services n (%)

Frequency	Very good	Good	Neither good nor bad	Bad	Very bad	*p*-value
Always	2 (5.7%)	12 (34.3%)	14 (40.0%)	5 (14.3%)	2 (5.7%)	
Frequently	0 (0.00%)	5 (13.8%)	21 (55.6%)	11 (30.6%)	0 (0.00%)	
Sometimes	1 (1.2%)	10 (12.8%)	39 (47.5%)	23 (29.5%)	7 (9.0%)	0.002
Rarely	3 (7.3%)	3 (7.3%)	15 (34.15%)	12 (29.3%)	9 (21.9%)	
ALL	6 (3.1%)	30 (15.8%)	90 (44.7%)	51 (26.7%)	18 (9.7%)	

Quality of SUS services n (%)

Frequency	Very good	Good	Neither good nor bad	Bad	Very bad	*p*-value
Always	4 (11.8%)	8 (23.5%)	14 (38.3%)	8 (23.5%)	1 (2.9%)	
Frequently	1 (2.7%)	5 (13.5%)	17 (43.3%)	15 (40.5%)	0 (0.0%)	
Sometimes	0 (0.00%)	14 (16.9%)	51 (60.2%)	14 (16.9%)	5 (6.0%)	0.000
Rarely	4 (10.8%)	8 (21.6%)	10 (24.4%)	9 (24.3%)	7 (18.9%)	
ALL	9 (4.7%)	35 (18.3%)	92 (46.1%)	46 (24.1%)	13 (6.8%)	

When questioned about the presence in the pharmacy of a qualified pharmacist at the time of medication acquisition, pharmacists were reported as generally not being present by users of SUS public pharmacies, with 60% declaring never having spoken with a pharmacist. Those who acquired medicines through public and private services reported the presence of a pharmacist *always* (18.8%), *frequently* (18.8%), and *sometimes* (43.8%).

Individuals who only acquired medicines through SUS pharmacies considered the role and/or contribution of the pharmacist as being indifferent to the guidance process for the use of the medication, and those who acquired medicines through both services (public and private) considered a pharmacist as *indispensable* and *essential* (*p*-value = 0.0005), as shown in Table 4.

Table 4. Perception of SUS users applied to pharmacists and their services (n = 195).

	Presence of the Pharmacist in the Pharmacy n (%)					
Acquisition of Medicines	**Always**	**Often**	**Sometimes**	**Rarely**	**Never**	***p*-Value**
Public Pharmacy	1 (10.0%)	2 (20.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	6 (60.0%)	
Public and Private	6 (18.8%)	6 (18.8%)	14 (43.8%)	5 (15.6%)	1 (3.1%)	0.001
ALL	7 (16.7%)	8 (19.1%)	15 (35.7%)	5 (11.8%)	7 (16.7%)	

	Role of the Pharmacist in patient guidance n (%)			
Acquisition of medicines	**Indispensable/Essential**	**Indifferent**	**Unnecessary**	***p*-value**
Public Pharmacy	2 (22.2%)	6 (66.7%)	1 (11.1%)	
Public and Private	42 (97.7%)	1 (2.3%)	0 (0.0%)	0.0005
ALL	44 (84.6%)	7 (13.5%)	1 (1.9%)	

In terms of accessing consultations with specialist SUS services, e.g., pediatric neurologists and cardiologists, consultations were available only in another municipality (*p*-value = 0.001). No statistically significant results (*p*-value > 0.05) were found in relation to the participants' views of infrastructure, workforce, and services, as shown in Table 5.

Table 5. Assessment and access quality of the public health services, n (%).

	Access to SUS Services n (%)			
Access to SUS Services	**Infrastructure**	**Health Professionals**	**Services**	***p*-Value**
Very good	7(77.8%)	2 (22.2%)	0 (0.0%)	
Good	24 (75.0%)	6 (18.7%)	2 (6.3%)	
Neither good nor bad	62 (75.6%)	11 (13.4%)	9 (11.0%)	0.88
Bad	33 (78.6%)	4 (9.5%)	5 (11.90%)	
Very bad	10 (76.9%)	1 (7.7%)	2 (15.4%)	
ALL	136 (76.4%)	24 (13.5%)	18 (10.1%)	

4. Discussion

We believe this is the first study to evaluate users' experiences of access to and quality of the public health services in the southeast of Brazil. The majority of participants used the public health system (97.5%) and the results demonstrated that SUS services such as vaccinations are used regularly by the Brazilian population. Strong primary health care is essential for responsive health services to be offered for the community [8,9]. However, these results highlight major deficiencies from the perspectives of users of SUS services in the structure, processes, informational, clinical and administrative/organizational activities of the SUS in Brazil [12,53].

Overall, only 23% of participants rated the quality of care to be *very good* or *good* and only 18.9% rated access as *very good* or *good.* Participants that used SUS services *frequently* and *sometimes*, 61.8% and 71.1%, respectively, reported the quality of the SUS public health services as *neither good nor bad*. Moreover, access to SUS services were rated as *neither good nor bad* by 86.2% of participants who used SUS services frequently and 77.7% of those who used SUS services *sometimes* (p-value = 0.002). These data also showed that some pregnant women reported that prenatal care services are unsatisfactory in some municipalities of this region. Moreover, only 26% of participants in this study reported always being able to obtain a desired medicine at SUS public pharmacies, including both OTC and prescription medicines. Boing and colleagues (2022) also found that many individuals were unable to obtain medication through the SUS, which was associated with inefficient access to SUS services [54]]. These results have, therefore, further demonstrated concerns by users of SUS services with the access to and quality of SUS healthcare services.

Almost half (47.5%) of the participants in this study reported having private health insurance, which is higher than the national average (~25%) [20], although those who had private health plans or health insurance also reported using some SUS services. The number of individuals who are able to use a mix of public and private health services resonates with previous research [53]. The higher frequency of individuals who have private health insurance in this sample must be seen in the context of the deficits in the access to and the quality of care in SUS services found in this study in these municipalities.

The Coastal Lowlands Region is a municipality with less than 100 thousand inhabitants and an infrastructure that is insufficient to meet some health demands, e.g., maternity and specialist consultation, as well as procedures such as surgeries and transplants [43]. Participants in this study reported not being able to access consultations with specialists in their municipality of residence. Regionalization is a principle that underpinned the construction of the SUS system to promote and enable strategies for access to public services for the population. Where people reside in municipalities that are "lacking in infrastructure", contingencies exist to provide free transport to consultations with specialists in other municipalities. According to Carvalho and collaborators (2017), the decentralized regionalization process has been instrumental in ensuring access to SUS services [[55].

In the pharmacy context, many municipalities in the Rio de Janeiro State do not provide some services and activities such as the Family Health Strategy and Basic Health Units. Moreover, in public SUS pharmacies, medication dispensing is mainly performed by another member of staff other than a pharmacist, which contextualizes our finding that a considerable percentage of participants had never seen a pharmacist the SUS public pharmacies (60%). Peixoto et al. (2022) [56] and Torrês et al. (2024) [57] have emphasized that the presence of a pharmacist increases and optimizes medication dispensing and the delivery of technical knowledge about medication use to patients, which was valued and recognized in our sample, especially by interviewees who use private pharmacies (value-p = 0.0005) The presence of a pharmacist also promotes the rational use of medicines [56,57].

The study aimed to identify the experiences and views of the users of SUS services in a socioeconomically deprived region of Rio de Janeiro. However, some limitations should be noted including the participation of only six out of nine municipalities in the Coastal Lowlands Region, which have the most relevant socioeconomic impact. However,

as presented in Table 1, the characteristics of the sample were similar to those of the Brazilian population as a whole [58]. The convenience sample used may not be generalizable to the wider population of Brazil. However, the convenience sample approach used in this study facilitated us to obtain a range of attitudes and opinions [50]. Despite these limitations, we believe the study has succeeded in its aim of identifying SUS service users' views on the access to and the quality of SUS health services in the Coastal Lowlands Region of Rio de Janeiro State.

5. Conclusions

This is a unique study focusing on one of the main regions of an important Brazilian State, providing evidence of users' perceptions of public SUS services. Overall, only 23% of participants rated the quality of care to be *very good* or *good* and only 18.9% rated access as *very good* or *good*, with more than 60% of SUS users assessing the access to and quality of SUS services as neither good nor bad. These findings highlight important priorities for improvement by SUS users for consideration by policy-makers in planning and delivering micro–meso–macro reforms to improve future access to and quality of responsive SUS services and universal health coverage.

Many people in Brazil are SUS dependent for healthcare. The SUS has been essential in promoting health and meeting the health needs of many of the Brazilian population, ensuring access to health services, promoting disease prevention, and contributing to the improvement of the quality of life of millions of Brazilians. Its important role is intrinsically linked to the improvement of the health of the population, promoting a primary care-led, more efficient, accessible, and patient-centered health system. These findings and their implications can help towards this goal.

Supplementary Materials: The following supporting information can be downloaded at: https://www.mdpi.com/article/10.3390/ijerph21060721/s1, Survey Instrument S1.

Author Contributions: Conceptualization, I.P.D.G.; methodology, I.P.D.G. and E.A.R.; software, J.S.S., E.A.R. and I.P.D.G.; validation, J.S.S., E.A.R. and I.P.D.G.; formal analysis, J.S.S., E.A.R. and I.P.D.G.; investigation, J.S.S., E.A.R. and I.P.D.G.; resources, J.S.S. and I.P.D.G.; data curation, J.S.S., E.A.R. and I.P.D.G.; writing—original draft preparation, J.S.S. and I.P.D.G.; writing—review and editing, J.S.S., E.A.R., B.G., S.M.C., J.C.M., L.W.P.S. and I.P.D.G. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Funding: This research received no external funding.

Institutional Review Board Statement: This study was conducted in accordance with the Declaration of Helsinki and was approved by the Research Ethics Committee of the Federal University of Rio de Janeiro/Macaé Campus (CAAE: 68864623.6.0000.5699).

Informed Consent Statement: Informed consent was obtained from all subjects involved in the study.

Data Availability Statement: The data presented in this study are available on request from the corresponding author. The data are not publicly available due to privacy and ethical restrictions.

Conflicts of Interest: The authors declare no conflicts of interest.

References

1. BRASIL. *Emenda Constitucional nº 29, de 13 de Setembro de 2000. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*; Presidência da República: Brasília, Brazil, 2000.
2. BRASIL. *Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990*; Presidência da República: Brasília, Brazil, 1990. Available online: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm (accessed on 15 January 2024).
3. BRASIL. *Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1990*; Presidência da República: Brasília, Brazil, 1990. Available online: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm (accessed on 29 February 2024).
4. BRASIL. *Emenda Constitucional nº 95, de 15 de Dezembro de 2016*; Presidência da República: Brasília, Brazil, 2016. Available online: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm (accessed on 29 February 2024).
5. Matta, G.C. Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. In *Políticas de Saúde: Organização e Operacionalização do Sistema Único de Saúde*; Matta, G.C., Pontes, A.L.d.M., Eds.; Coleção Educação Profissional e Docência em Saúde: A formação e o trabalho do agente comunitário de saúde, 3; EPSJV/FIOCRUZ: Rio de Janeiro, Brazil, 2007; pp. 61–80.
6. Ministry of Health. *Portaria N° 4.279, de 30 de Dezembro de 2010. Estabelece Diretrizes Para a Organização da Rede de Atenção à Saúde no Âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)*; Ministry of Health: Brasília, Brazil, 2010.
7. Castro, M.C.; Massuda, A.; Almeida, G.; Menezes-Filho, N.A.; Andrade, M.V.; de Souza Noronha, K.V.M.; Rocha, R.; Macinko, J.; Hone, T.; Tasca, R.; et al. Brazil's unified health system: The first 30 years and prospects for the future. *Lancet* **2019**, *394*, 345–356. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31243-7. PMID: 31303318.
8. Starfield, B.; Shi, L.; Macinko, J. Contribution of Primary Care to Health Systems and Health. *Milbank Q.* **2005**, *83*, 457–502.
9. NESCON. *Atenção Primária deve Solucionar a Maioria dos Problemas de Saúde*; Nescon/UFMG: Belo Horizonte, Brazil, 2015. Available online: https://www.nescon.medicina.ufmg.br/atencao-primaria-deve-solucionar-maioria-dos-problemas-de-saude/ (accessed on 16 January 2024).
10. World Health Organization; Organization for Economic Co-operation and Development & International Bank for Reconstruction and Development. *Delivering Quality Health Services: A Global Imperative for Universal Health Coverage*; World Health Organization: Geneva, Switzerland, 2018. Available online: https://iris.who.int/handle/10665/272465 (accessed on 10 January 2024).
11. Macinko, J.; Starfield, B.; Shi, L. The Contribution of Primary Care Systems to Health Outcomes within Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Countries, 1970–1998. Health Serv. Res. **2003**, *38*, 831–865.
12. Simão, C.C.A.L.; Costa, M.B.; Colugnati, F.A.B.; de Paula, E.A.; Vanelli, C.P.; de Paula, R.B. Quality of Care of Patients with Diabetes in Primary Health Services in Southeast Brazil. J. Environ. Public Health **2017**, 2017, e1709807. Available online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5654281/pdf/JEPH2017-1709807.pdf (accessed on 29 March 2024).
13. Senn, N.; Breton, M.; Ebert, S.T.; Lamoureux-Lamarche, C.; Lévesque, J.F. Assessing primary care organization and performance: Literature synthesis and proposition of a consolidated framework. Health Policy **2021**, *125*, 160–167.
14. Ministry of Health. *Portaria Programa Nacional de Imunizações—Vacinação*; Ministry of Health: Brasília, Brazil, 2023.
15. Cmas, D.; Maranhão, A.G.K.; Teixeira, A.M.; Fantinato, F.F.S.; Domingues, R.A.S. 46 Anos do Programa Nacional de Imunizações: Uma História Repleta de Conquistas e Desafios a Serem Superados. *Cad Saúde Pública [Internet]* **2020**, *36*, e00222919. https://doi.org/10.1590/0102-311X00222919.
16. Ministry of Health. *Vacinômetro COVID-19*; Ministry of Health: Brasília, Brazil, 2024. Available online: https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_Vacina_C19/SEIDIGI_DEMAS_Vacina_C19.html (accessed on 29 March 2024).
17. IBGE. *Censo 2022. De 2010 2022, População Brasileira Cresce 6.5% e Chega a 203.1 Milhõe*; IBGE: Brasília, Brazil, 2023.
18. BRASIL. *Lei nº. 141, de 13 de Janeiro de 2012*; Diário Oficial da União: Brasília, Brazil, 2012.
19. Ministry of Health. *Conselho Nacional de Saúde Recomenda Ampliação de Recursos para o SUS e Garantia do piso Constitucional*; Ministry of Health: Brasília, Brazil, 2023.
20. ANS NEW. Beneficiários de Planos Privados de Saúde, por Cobertura Assistencial (Brasil—2014–2024). Available online: https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/perfil-do-setor/dados-gerais (accessed on 22 May 2024).
21. Samuelson-Kiraly, C.; Montague, T.; Nemis-White, J.; MacPherson, N.; Martin, L.; Aylen, J.; Gogovor, A.; Mitchell, J.I. Access and quality of health care in Canada: Insights from 1998 to the presents. *Healthc Manage Forum*. 2020, *33*, 6, 253-258.
22. ANS. Dados Gerais. In *Beneficiários de Planos Privados de Saúde, por Cobertura Assistencial (Brasil—2013–2023)*; ANS: Brasília, Brazil, 2024. Available online: https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/perfil-do-setor/dados-gerais (accessed on 30 March 2024).
23. Godói, I.P.; Santos, A.S.; Reis, E.A.; Lemos, L.L.P.; Brandão, C.M.R.; Alvares, J.; Acurcio, F.A.; Godman, B.; Guerra Júnior, A.A. Consumer Willingness to Pay for Dengue Vaccine (CYD-TDV, Dengvaxia®) in Brazil; Implications for Future Pricing Considerations. Front. Pharmacol. **2017**, *8*, 41.
24. Campbell, S.M.; Roland, M.O.; Buetow, S.A. Defining quality of care. *Soc. Sci. Med.* **2000**, 51, 1611–1625. Available online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11072882/ (accessed on 29 March 2024).
25. Agency for Healthcare Research and Quality. Six Domains of Health Care Quality. Available online: https://www.ahrq.gov/talkingquality/measures/six-domains.html (accessed on 30 March 2024).
26. Stopa, S.R.; Malta, D.C.; Monteiro, C.N.; Szwarcwald, C.L.; Goldbaum, M.; Cesar, C.L.G. Use of and access to health services in Brazil, 2013 National Health Survey. Rev. *Saúde Pública* **2017**, *51* (Suppl. 1), 3s.
27. De Fátima Vasques Monteiro, M.; Barbosa, C.P.; Vertamatti, M.A.F.; Tavares, M.N.A.; de Oliveira Carvalho, A.C.; Alencar, A.P.A. Access to public health services and integral care for women during the puerperal gravid period period in Ceará, Brazil.

BMC Health Serv. Res. **2019**, 19, 851. Available online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6868722/ (accessed on 29 March 2024).
28. Vilarins, G.C.M.; Pinho, D.L.M. Application of conceptual mapping in the regulation of access to public health services in the Federal District, Brazil. *Ciência Saúde Coletiva* **2021**, *26*, 5829–5840. Available online: https://www.scielo.br/j/csc/a/WJ9KwSsQXcvcRsvc864VBgb/?lang=pt (accessed on 29 March 2024).
29. Bittencourt, S.D.D.A.; Domingues, R.M.; Reis, L.G.; Ramos, M.M.; Leal, M.D. Adequacy of public maternal care services in Brazil. *Reprod.* Health **2016**, 13, 120. Available online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27766964/ (accessed on 29 March 2024).
30. Pinto, R.d.S; Roncalli, A.G.; Abreu, M.H.; Vargas, A.M. Use of Public Oral Health Services by the Adult Population: A Multilevel Analysis. *PLoS ONE* **2016**, 11, e0145149. Available online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26730714/ (accessed on 29 March 2024).
31. Hercos, B.V.S.; Berezovsky, A. Quality of the ophthalmological service to outpatients of the public and private healthcare systems. Arq. Bras. Oftalmol. **2017**, *80*, 350–354. Available online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29267568/ (accessed on 29 March 2024).
32. Carvalho, M.; Queiroz, A.B.A.; Ferreira, M.A.; Moura, M.A.V.; Pinto, C.B.; Vieira, B.D.G. Ineffectiveness of information and access to health services: Vulnerability to human papillomavirus. *Int. Nurs. Rev.* **2019**, 66, 280–289. Available online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30815859/ (accessed on 29 March 2024).
33. Soeiro, O.M.; Tavares, N.U.L.; Do Nascimento Júnior, J.M.; Guerra Junior, A.A.; Costa, E.A.; de Assis Acurcio, F.; Guibu, I.A.; Álvares, J.; de Oliveira Karnikowski, M.G.; Leite, S.N.; et al. Patient satisfaction with pharmaceutical services in Brazilian primary health care. Rev. *Saúde Pú-Blica (Online)* **2017**, *51*, 1S–11S.
34. Garcia, M.M.; Azevedo, P.S.; Mirelman, A.; Safatle, L.P.; Iunes, R.; Bennie, M.C.; Godman, B.; Guerra Junior, A.A. Funding and Service Organization to Achieve Universal Health Coverage for Medicines: An Economic Evaluation of the Best Investment and Service Organization for the Brazilian Scenario. *Front. Pharmacol.* **2020**, *11*, 370.
35. Souza, E.C.F.D.; de Vilar, R.L.A.; De Sá Pinto Dantas Rocha, N.; da Costa Uchôa, S.A.; de Medeiros Rocha, P. Acesso e acolhimento na atenção básica: Uma análise da percepção dos usuários e profissionais de saúde. *Cad. Saúde Pública Rio Jan.* **2008**, *24* (Suppl. 1), s100–s110.
36. WHO Library Cataloguing; World Health Organization. Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030; WHO: Geneva, Switzerland, 2016.
37. WHO Library Cataloguing; World Health Organization. Monitoring the Building Blocks of Health Systems: A Handbook of Indicators and Their Measurement Strategies; WHO: Geneva, Switzerland, 2010.
38. OECD. Primary Health Care in Low- and Middle-Income Countries. Realizing the Potential of Primary Health Care. OECD iLibrary. Available online: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5a3b7d49-en/index.html?itemId=/content/component/5a3b7d49-en (accessed on 22 January 2024).
39. The Commonwealth Fund. Mirror, Mirror 2021: Reflecting Poorly. Available online: https://www.commonwealthfund.org/publications/fund-reports/2021/aug/mirror-mirror-2021-reflecting-poorly (accessed on 22 January 2024).
40. Nunes, L.O.; Castanheira, E.R.L.; Sanine, P.R.; Akerman, M.; Nemes, M.I.B. Performance assessment of primary health care facilities in Brazil: Concordance between web-based questionnaire and in-person interviews with health personnel. *PLoS ONE* **2023**, *18*, e0281085.
41. IBGE. *Panorama*; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: Rio de Janeiro, Brazil, 2022. Available online: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/panorama (accessed on 18 February 2024).
42. Kuschnir, R.; Chorny, A.; Lira, A.M.L.E.; Sonoda, G.; Fonseca, T.M.P. *Regionalização no Estado do Rio de Janeiro: O Desafio de Aumentar Acesso e Diminuir Desigualdades. A Gestão do SUS no Âmbito Estadual: O Caso do Rio de Janeiro*; Editora FIOCRUZ: Rio de Janeiro, Brazil, 2010; pp. 215–240.
43. *Diagnóstico de Saúde da Região da Baixada Litorânea*; Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, Brazil 2020. Available online: https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MzUwNzA%2C (accessed on 28 February 2024).
44. Rio da Ostras.*Dados Municipais*; Prefeitura Municipal de Rio das Ostras: Rio de Janeiro, Brazil, 2024. Available online: https://www.riodasostras.rj.gov.br/dados-municipais/#:~:text=O%20resultado%20do%20Censo%202022,foi%20de%2048%2C09%25 (accessed on 29 March 2024).
45. Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Relação de Municípios do Estado do Rio de Janeiro por data de adesão, Brazil, 2024. Available online: https://www.defesacivil.rj.gov.br/index.php/cidades-resilientes/item/61-relacao-de-municipios-do-estado-do-rio-de-janeiro-por-data-de-adesao (accessed on 30 *May* 2024).
46. IBGE. Dados Sobre Estados Brasileiros. Panorama Cabo Frio, Brazil, 2023. Available online: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/cabo-frio/panorama (accessed on 18 February 2024).
47. IBGE. Dados Sobre Estados Brasileiros. Panorama Rio das Ostras, Brazil, 2023. Available online: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/rio-das-ostras/panorama (accessed on 18 February 2024).
48. Ministry of Health. *Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Componente Populacional: Introdução, Método e Instrumentos/Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos*; il.—Série Pnaum—Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos no Brasil; Caderno 1; Ministério da Saúde: Brasília, Brazil, 2016; 80p.
49. Ministry of Health. *Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ)*; Ministry of Health: Brasília, Brazil, 2011. Available online: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pmaq (accessed on 23 February 2024).

50. Galloway, A. Convenience Sampling—An Overview|ScienceDirect Topics. *Encyclopedia of Social Measurement. Non-Probability Sampling—Convenience Sampling*; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, 2005; ISSB 978-0-12-369398-3. Available online: https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/convenience-sampling#:~:text=Convenience%20Sampling-,Definition,in%20a%20workplace%2C%20for%20example (accessed on 23 May 2024).
51. BRASIL. *Histórico de Cotação*; Banco Central do Brasil: Brasília, Brazil, 2023. Available online: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes (accessed on 22 February 2024).
52. BRASIL. *Lei n. 14.663, de 28 de Agosto de 2023*; Presidência da República: Brasília, Brazil, 2023. Available online: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Lei/L14663.htm (accessed on 22 February 2024).
53. Bousquat, A.; Giovanella, L.; Campos, E.M.S.; Almeida, P.F.; Martins, C.L.; Mota, P.H.D.S.; Mendonça, M.H.M.; Medina, M.G.; Viana, A.L.D.; Fausto, M.C.R.; et al. Primary health care and the coordination of care in health regions: managers' and users' perspective. Cienc. Saude Coletiva **2017**, 22, 1141–1154. Available online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28444041/ (accessed on 29 March 2024).
54. Boing, A.; Andrade, F.; Bertoldi, A.; Glazer, K.; Peres, A.; Massuda, A.; Boing, A. Prevalências e desigualdades no acesso aos medicamentos por usuários do Sistema Único de Saúde no Brasil em 2013 e 2019. *Cad. Saúde Pública* **2022**, *38*, e00114721. https://doi.org/10.1590/0102-311XPT114721.
55. De Carvalho, A.L.B.; de Jesus, W.L.A.; Senra, I.M.V.B. Regionalization in the SUS: Implementation process, challenges and perspectives in the critical view of system managers. *Ciência Saúde Coletiva* **2017**, *22*, 1155–1164. Available online: https://www.scielo.br/j/csc/a/X5tq3bQgN8XkGkths95ctkz/?lang=en# (accessed on 20 May 2024).
56. Peixoto, R.T.; Campos, M.R.; Luiza, V.L.; Mendes, L.V. O farmacêutico na Atenção Primária à Saúde no Brasil: Análise comparativa 2014–2017. Saúde Debate **2022**, 46, 358–375. Available online: https://www.scielo.br/j/sdeb/a/3LgFkWC3ryTCc79YQnhSmdv/?format=pdf&lang=pt (accessed on 22 January 2024).
57. Tôrres, L.L.; Azevedo, P.S.; Rocha Sarmento, T.T.; Ramalho-de-Oliveira, D.; Reis, E.A.; Dias Godói, I.P.; Guerra Júnior, A.A.; Ruas, C.M. Acceptability and consumers' willingness to pay for comprehensive medication management services in Brazil. J. Comp. Eff. Res. **2024**, *13*, e230127.
58. IBGE. *Síntese de Indicadores Sociais: Uma Análise das Condições de Vida da População Brasileira*; IBGE: Brasilia, Brazil, 2014. Available online: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91983.pdf (accessed on 30 March 2024).

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.